Las GPC identificadas, deben cumplir con todos los criterios obligatorios:

Criterios obligatorios

1. Año de publicación no mayor a 5 años
2. Coincide con el alcance de la VCIS a elaborar.
3. Describe el proceso de desarrollo de la GPC.
4. Brinda información sobre la conformación del grupo elaborador.
5. Aborda preguntas claras (se pueden identificar los componentes PICO)
6. Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura (múltiples bases de datos y se incluyen todos los términos clave) para cada una de las preguntas.
7. Es replicable la búsqueda de la evidencia (las estrategias de búsqueda están disponibles).
8. Se emiten recomendaciones y es posible identificar la evidencia que las respalda (Cada recomendación está enlazada a una descripción de la evidencia y/o tabla de evidencia).

Criterios deseables

1. Utiliza la metodología GRADE para valorar la certeza de la evidencia y las tablas de evidencia están disponibles (perfil de evidencia o resumen de hallazgos).
2. Utiliza la metodología GRADE para formular las recomendaciones mediante el marco de Evidencia a la Decisión disponible en tablas o formato narrativo.

El equipo elaborador evalúa cada criterio por GPC identificada y registra la respuesta como "Sí" o "No" en la herramienta.

Las GPC que no cumplan con uno o más de los criterios obligatorios se evalúan con la herramienta AGREE II.

Las GPC no elaboradas bajo la metodología vigente del Ministerio de Salud, también se evalúan con la herramienta AGREE II.

La evaluación con AGREE II debe considerar que la puntuación de la calidad en la evaluación global de la GPC debe ser mayor del 60%, en base al promedio de la calificación de los seis dominios según el instrumento del AGREE II. Así mismo la puntuación de la calidad debe ser mayor del 60% en cada uno de los siguientes dominios: alcance y objetivos, rigor metodológico y aplicabilidad.

C. ALVARADO CH.

Las GPC aprobadas por el Ministerio de Salud, el Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud del Instituto Nacional de Salud, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación de EsSalud o las Guías de la Organización Mundial de la Salud, que cumplan con los criterios obligatorios o la puntuación de calidad establecida en el AGREE II serán consideradas para el soporte de las intervenciones de salud preseleccionadas.

Las GPC que cumplen el criterio del AGREE II, pero que no fueron aprobadas por el Ministerio de Salud, el Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud del Instituto Nacional de Salud, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación de EsSalud o las Guías de la Organización Mundial de la Salud, serán consideradas para su evaluación en el siguiente paso.

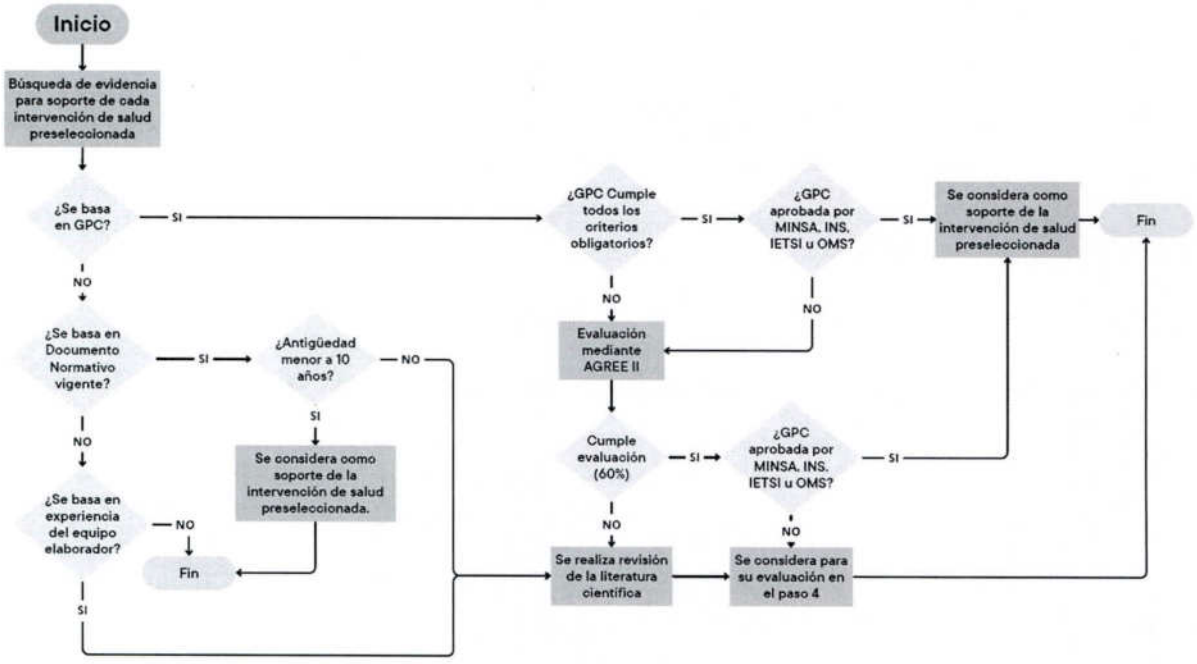
En caso la intervención de salud preseleccionada, no cuente con GPC que cumpla con los criterios antes mencionados o en ausencia de un documento normativo o cuando este último supera los diez años de antigüedad, el equipo elaborador realiza la revisión de la literatura científica, según lo dispuesto en el numeral 6.2.2.2.5 de la presente NTS.

Luego de cada sesión, el coordinador o algún integrante del equipo elaborador delegado, redacta el acta que contenga como mínimo lo siguiente:

1. Datos de identificación: Nombre de la reunión, fecha, hora de inicio y cierre, lugar o medio virtual, y número de sesión.
2. Participantes: nombres completos, cargos e institución de los asistentes.
3. Agenda u orden del día.
4. Desarrollo de las actividades: resumen de los temas tratados y principales aportes.
5. Registro de la Herramienta 5 (con avances o finalizada, según corresponda).
6. Acuerdos y compromisos: detalle de las decisiones, responsables y plazos.
7. Próxima fecha de reunión.
8. Firmas del coordinador, del responsable del acta y de los asistentes.

El siguiente flujo ilustra este paso:

PASO 3: Revisión de la evidencia científica y/o Documento Normativo vigente



MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

Ejemplo del registro de la Herramienta 5: Selección de Guías de Práctica Clínica

Ejemplo de registro herramienta 5: Selección de Guías de Práctica Clínica						
VCIS	**CÁNCER DE CUELLO UTERINO**					
Criterio de preselección	**GPC 1: XX**	**GPC 2: XX**	**GPC 3: XX**	**GPC 4: XX**	**GPC 5: XX**	**GPC "n": XX**
1. ¿El año de publicación es menor a los 5 años?	Si	Si	No	Si	Si	Si
2. ¿Coincide con el alcance de la VCIS a desarrollar? (En caso de coincidencia parcial especificar qué aspectos cubre: Diagnóstico, tratamiento, prevención, otros)	Si	Si	Si	Si	Si	Si
3. ¿Se describe el proceso de desarrollo de la guía y brinda información sobre la conformación del grupo elaborador?	Si	Si	Si	Si	Si	Si
4. ¿Aborda preguntas claras? (se pueden identificar los componentes PICO)	Si	No	No	Si	Si	Si
5. ¿Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura para cada una de las preguntas? (múltiples bases de datos, se incluyen todos los términos claves)	Si	Si	No	Si	Si	Si
6. ¿Es replicable la búsqueda de evidencia? (Las estrategias de búsqueda están disponibles)	Si	Si	No	Si	Si	Si
7. ¿Se emiten recomendaciones y es posible identificar la evidencia que las respalda? (Cada recomendación está enlazada a una descripción de la evidencia y/o tabla de evidencia)	Si	Si	No	Si	Si	Si
8. ¿Utilizó la metodología GRADE para valorar la certeza de la evidencia y las tablas de evidencia están disponibles? (¿Perfil de evidencia o Resumen de hallazgos? (ideal)	Si	Si	No	Si	Si	Si
9. ¿Utilizó la metodología GRADE para formular las recomendaciones? (el marco de la Evidencia a la Decisión (EtD) está disponible (tablas o narrativo)? (ideal)	Si	Si	No	Si	Si	Si
Elegible para evaluación mediante AGREE II	No	Si	Si	No	No	No

C. ALVARADO CH.

Ejemplo referencial

ANEXO 10
Herramienta 6: Construcción de la estrategia PICO

Herramienta 6: Construcción de la estrategia PICO			
VCIS			
Intervención de Salud	**Intervención de salud individual**	**Pregunta de investigación**	**Estrategia PICO**
Promoción de la salud	Intervención de salud individual 1		P: I: C: O:
Prevención de la enfermedad	Intervención de salud individual 2		P: I: C: O:
Diagnóstico	Intervención de salud individual 3		P: I: C: O:
Tratamiento	Intervención de salud individual 4		P: I: C: O:
Rehabilitación de la salud	Intervención de salud individual 5		P: I: C: O:
Cuidados paliativos	Intervención de salud individual 6		P: I: C: O:
Intervención de salud pública		**Pregunta de investigación**	**Estrategia PICO**
Intervención de salud pública 1			P: I: C: O:
Intervención de salud pública 2			P: I: C: O:

C. ALVARADO CH.

Instructivo de la herramienta 6: Construcción de la Estrategia PICO

Para aquellas intervenciones de salud preseleccionadas que no cuenten con GPC o no cumplan con los criterios señalados en la herramienta 5 o ausencia de documento normativo relacionado con el alcance de la VCIS el equipo elaborador realiza la revisión de la literatura científica y considera lo siguiente:

- Construcción de la estrategia PICO y generación de la pregunta de investigación para cada intervención de salud preseleccionada.
- Estrategia de búsqueda de evidencia científica.
- Selección y valoración de la evidencia científica (GPC, revisiones sistemáticas y metaanálisis).
- Extracción de datos relevantes para la elaboración de la VCIS.

La herramienta para la construcción de la Estrategia PICO tiene como finalidad dar soporte instrumental al proceso de generar una pregunta de investigación para cada intervención de salud preseleccionada en términos de su efectividad y seguridad. La herramienta está estructurada en una matriz que permite construir la pregunta de investigación a través de la estrategia PICO.

La estrategia PICO es llamada así debido a que representa un acrónimo en inglés para describir los componentes que la integran: Population, Intervention, Comparison, Outcome.

Acrónimo y componente	Descripción de los componentes
P. Paciente o problema de interés (Population)	Paciente o grupo con una condición en particular, se trata de destacar las características del paciente que puedan contribuir a delimitar la búsqueda de información.
I. Intervención (Intervention)	Manejo o intervención de interés, misma que puede ser terapéutica, preventiva, diagnóstica o de pronóstico.
C. Comparación (Comparison)	Se trata de una intervención alternativa con la cual comparar, aunque no siempre se dispone de la misma, en cuyo caso se omite este componente y el formato se convierte en PIO.
O. Resultados (Outcome)	Se trata de las consecuencias relevantes de interés, el resultado esperado de la intervención.

MINISTERIO DE SALUD
C. ALVARADO CH.

El equipo elaborador en sesión y con previo conocimiento del objetivo de la actividad, genera una pregunta de investigación para cada intervención de salud preseleccionada. A continuación, se presenta un ejemplo del uso de la estrategia PICO para construir una pregunta de investigación.

Acrónimo y componente	Descripción de los componentes
P. Paciente o problema de interés (Population)	Pacientes adultos con insuficiencia mitral severa primaria y/o secundaria que persisten sintomáticos a pesar de recibir tratamiento farmacológico de soporte y tienen alto riesgo quirúrgico o contraindicación quirúrgica.
I. Intervención (Intervention)	Reparación de válvula mitral por transcateter de borde a borde con clip
C. Comparación (Comparison)	Tratamiento farmacológico de soporte

O. Resultados (Outcome)	Eficacia: *Mortalidad *Re-hospitalización por insuficiencia cardiaca *Severidad de insuficiencia mitral *Mejoría clínica se insuficiencia mitral *Calidad de vida Seguridad *Eventos adversos

Luego de cada sesión, el coordinador o algún integrante del equipo elaborador delegado, redacta el acta que contenga como mínimo lo siguiente:

1. Datos de identificación: Nombre de la reunión, fecha, hora de inicio y cierre, lugar o medio virtual, y número de sesión.
2. Participantes: nombres completos, cargos e institución de los asistentes.
3. Agenda u orden del día.
4. Desarrollo de las actividades: resumen de los temas tratados y principales aportes.
5. Registro de la Herramienta 6 (con avances o finalizada, según corresponda).
6. Acuerdos y compromisos: detalle de las decisiones, responsables y plazos.
7. Próxima fecha de reunión.
8. Firmas del coordinador, del responsable del acta y de los asistentes.

MINISTERIO DE SALUD
C. ALVARADO CH.

Ejemplo del registro de la Herramienta 6: Construcción de la Estrategia PICO

Ejemplo de registro herramienta 6: Construcción de la estrategia PICO			
VCIS	**CÁNCER DE CUELLO UTERINO**		
Intervención de Salud	**Intervención de salud individual**	**Pregunta de investigación**	**Estrategia PICO**
Promoción de la salud	Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer	¿Qué tan efectiva es la consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer en promover la adopción de comportamientos preventivos en adultos con riesgo elevado?	**P**: Personas mayores de 18 años con factores de riesgo conocidos para el cáncer (como tabaquismo, consumo de alcohol, sedentarismo, dieta inadecuada, antecedentes familiares, etc.).
			I: Consejería preventiva personalizada sobre la identificación y modificación de factores de riesgo para el cáncer
			C: Ausencia de la intervención de salud (no realizar)
			O: Cambios positivos en los comportamientos preventivos
Prevención de la enfermedad	*Intervención de salud "n"*	*XX*	*P: XX*
			I: XX
			C: XX
			O: XX
Diagnóstico	*Intervención de salud "n1"*	*XXX*	*P: XX*
			I: XX
			C: XX
			O: XX
Tratamiento	*Intervención de salud "n2"*	*XXX*	*P: XX*
			I: XX
			C: XX
			O: XX

C. ALVARADO CH.

Rehabilitación	*Intervención de salud "n3"*	*XXX*	*P: XX*
			I: XX
			C: XX
			O: XX
Cuidados paliativos	*Intervención de salud individual "n4"*	*XXX*	*P: XX*
			I: XX
			C: XX
			O: XX
Intervención de salud pública		**Pregunta de investigación**	**Estrategia PICO**
Promover ambientes 100% libres de humo		¿Qué tan efectiva es la promoción de ambientes 100% libres de humo en reducir la exposición al humo de tabaco en espacios públicos y laborales?	P: Usuarios y trabajadores de espacios públicos y laborales
			I: Implementación de estrategias para promover y garantizar ambientes 100% libres de humo
			C: Ausencia de promoción activa o ambientes sin regulación específica.
			O: Reducción en la incidencia de cáncer relacionado con el tabaquismo en áreas 100% libres de humo
Intervención de salud pública n		*XX*	*P: XX*
			I: XX
			C: XX
			O: XX

C. ALVARADO CH.

Ejemplo referencial

ANEXO 11

Herramienta 7: Estrategia de búsqueda de evidencia científica

Herramienta 7: Estrategia de búsqueda de evidencia científica					
VCIS					
Intervención de salud	**Intervención de salud individual**	**Fecha de búsqueda**	**Base de datos consultadas**	**Términos de búsqueda**	**Número de Referencias identificadas**
Promoción de la salud	Intervención de salud 1		PubMed		
			LILACS		
			Cochrane Library		
			"n"		
Prevención de la enfermedad	Intervención de salud 2		PubMed		
			LILACS		
			Cochrane Library		
			"n"		
Diagnóstico	Intervención de salud 3		PubMed		
			LILACS		
			Cochrane Library		
			"n"		
Tratamiento	Intervención de salud 4		PubMed		
			LILACS		
			Cochrane Library		
			"n"		
Rehabilitación de la salud	Intervención de salud 5		PubMed		
			LILACS		
			Cochrane Library		
			"n"		
Cuidados paliativos	Intervención de salud "n"		PubMed		
			LILACS		
			Cochrane Library		
			"n"		
Intervenciones de salud pública		**Fecha de búsqueda**	**Base de datos consultadas**	**Términos de búsqueda**	**Número de Referencias identificadas**
Intervención de salud pública 1			PubMed		
			LILACS		
			Cochrane Library		
			"n"		
Intervención de salud pública "n"			PubMed		
			LILACS		
			Cochrane Library		
			"n"		

MINISTERIO DE SALUD
C. ALVARADO CH.

Instructivo de la herramienta 7: Estrategia de búsqueda de evidencia científica

Esta herramienta tiene como finalidad dar soporte instrumental al proceso de una búsqueda eficiente de evidencia científica, entendiendo el término "eficiente" como la mejor evidencia científica con una estrategia de búsqueda sencilla y replicable, para reportar de manera prioritaria estudios relevantes para los términos de búsqueda definidos.

El equipo elaborador en sesión y con previo conocimiento del objetivo de la actividad, ejecuta la búsqueda de la evidencia científica en bases de datos electrónicas sistematizadas en salud como: MEDLINE, EMBASE, LILACS, entre otras.

La búsqueda se realiza en un mínimo de dos bases de datos electrónicas sistematizadas. Son obligatorias: MEDLINE y LILACS. Pueden incluir bases adicionales según el alcance de la VCIS.

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS	
MEDLINE	PubMed (nih.gov)
EMBASE	https://www.elsevier.com/solutions/embase-biomedical-research
CENTRAL	https://www.cochranelibrary.com/central
LILACS	Search | VHL Regional Portal (bvsalud.org)
CINHAL	CINAHL Complete | EBSCO

El equipo elaborador para la búsqueda de evidencia científica puede solicitar la colaboración, asesoramiento, apoyo, opinión y/o aporte técnico de profesionales especialistas invitados ya sean de unidades al interior de los Institutos de Salud Especializados o profesionales del Instituto Nacional de Salud de acuerdo con disponibilidad y además se debe contar con acceso a las bases de datos electrónicas.

C. ALVARADO CH.

Los integrantes del equipo elaborador de la VCIS con perfil de metodología de la investigación coordinan el proceso y entregan los resultados obtenidos. El tamizaje de artículos y la extracción y análisis de datos se realiza por pares de revisores independientes.

Tomar en cuenta para la construcción de la estrategia de búsqueda la utilización de términos puntuales de búsqueda como palabras del título, palabras clave (MeSH), operadores booleanos entre otros.

TIPO DE TÉRMINO	DEFINICIÓN	SIGLA	EJEMPLO
Titulo	Acotara la búsqueda de la literatura por términos que se encuentren únicamente en el titulo	ti	health system[ti]
Palabras clave	Acota la búsqueda solamente a las palabras que se encuentren en las palabras clave del resumen de cada uno de los estudios	MeSH	Health services[MeSH]

TIPO DE TÉRMINO	DEFINICIÓN	SIGLA	EJEMPLO
Operadores booleanos	Poder relacionar diferentes términos en una búsqueda donde los dos términos tienen que estar simultáneamente mencionados en los estudios	AND	Health system AND governance
	Poder relacionar diferentes términos en una búsqueda donde uno o ambos términos pueden estar mencionados en los estudios	OR	Health system OR governance
	Relación de exclusión de un término de manera explicita	NOT	Health system NOT governance

Por tipo de pregunta de investigación se puede utilizar estrategias de búsqueda diferenciadas (diagnóstico, tratamiento, pronóstico, etiología, economía de la salud), en términos de búsquedas sensibles y específicas, utilizando herramientas para acotar la búsqueda de la literatura. Puede consultarlas en el siguiente enlace:

http://hiru.mcmaster.ca/hiru/HIRU_Hedges_MEDLINE_Strategies.aspx

Base de datos	PubMed Fecha de búsqueda: 28 de setiembre de 2022		Resultado
Estrategia	#1	(Mitral Valve Insufficiency[Mesh] OR Mitral Insufficien*[tiab] OR Valve Insufficien*[tiab] OR Mitral Regurgit*[tiab] OR Mitral Incompeten*[tiab]) AND (Mitral Valve Annuloplast*[Mesh] OR Mitral Annuloplast*[tiab] OR Valve Annuloplast*[tiab] OR Valve Repair*[tiab]) AND (Transcatheter[tiab] OR MitraClip[tiab] OR Pascal[tiab] OR Percutaneous Repair [tiab] OR TEER [tiab]) AND (Systematic Review[sb] OR Systematic Review[tiab] OR Meta-Analysis[pt] OR Meta-Analys*[tiab] OR "Cochrane Database Syst Rev"[ta] OR Metaanalysis[tiab] OR Metanalysis[tiab] OR Randon OR Controlled Trial.	162



Luego de cada sesión, el coordinador o algún integrante del equipo elaborador delegado, redacta el acta que contenga como mínimo lo siguiente:

1. Datos de identificación: Nombre de la reunión, fecha, hora de inicio y cierre, lugar o medio virtual, y número de sesión.
2. Participantes: nombres completos, cargos e institución de los asistentes.
3. Agenda u orden del día.
4. Desarrollo de las actividades: resumen de los temas tratados y principales aportes.
5. Registro de la Herramienta 7 (con avances o finalizada, según corresponda).
6. Acuerdos y compromisos: detalle de las decisiones, responsables y plazos.
7. Próxima fecha de reunión.
8. Firmas del coordinador, del responsable del acta y de los asistentes.

Ejemplo del registro de la Herramienta 7: Estrategia de búsqueda de evidencia científica

Ejemplo de registro herramienta 7: Estrategia de búsqueda de evidencia científica					
VCIS	**CÁNCER DE CUELLO UTERINO**				
Intervención de salud	**Intervención de salud individual**	**Fecha de búsqueda**	**Base de datos consultadas**	**Términos de búsqueda**	**Número de Referencias identificadas**
Promoción de la salud	Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer	9/12/2024	PubMed	"cancer prevention counseling"[ti], "risk factors"[ti], "behavioral intervention"[ti], "health counseling"[ti], "cancer prevention"[ti]	245
			LILACS	"consejería preventiva", "factores de riesgo cáncer", "intervención conductual", "prevención del cáncer"	98
			Cochrane Library	"cancer prevention counseling", "risk factors", "interventions for cancer prevention", "behavioral counseling", "public health interventions"	42
			"n"	XX	XX
Prevención de la enfermedad	*Intervención de salud pública "n"*	*XXX*	*PubMed*	XX	XX
			LILACS	XX	XX
			Cochrane Library	XX	XX
			"n"	XX	XX
Diagnóstico	*Intervención de salud pública "n1"*	*XXX*	*PubMed*	XX	XX
			LILACS	XX	XX
			Cochrane Library	XX	XX
			"n"	XX	XX
Tratamiento	*Intervención de salud pública "n2"*	*XXX*	*PubMed*	XX	XX
			LILACS	XX	XX
			Cochrane Library	XX	XX
			"n"	XX	XX

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General
C. ALVARADO CH.

Rehabilitación de la salud	*Intervención de salud pública "n3"*	*XXX*	*PubMed*	XX	XX
			LILACS	XX	XX
			Cochrane Library	XX	XX
			"n"	XX	XX
Cuidados paliativos	*Intervención de salud pública "n4"*	*XXX*	*PubMed*	XX	XX
			LILACS	XX	XX
			Cochrane Library	XX	XX
			"n"	XX	XX
Intervenciones de salud pública		**Fecha de búsqueda**	**Base de datos consultadas**	**Términos de búsqueda**	**Número de Referencias identificadas**
Promover ambientes 100% libres de humo		9/12/2024	PubMed	"smoke-free environments", "tobacco control", "smoke-free policy", "tobacco smoke exposure", "public health tobacco prevention", "smoking ban"	320
			LILACS	"ambientes libres de humo", "control del tabaco", "política libre de humo", "exposición al humo de tabaco", "prevención del tabaco en salud pública"	58
			Cochrane Library	"smoke-free environments", "tobacco control", "smoking ban", "tobacco smoke exposure", "public health tobacco prevention", "smoking cessation policy"	65
			"n"	XX	XX
Intervención de salud pública "n"			*PubMed*	*XX*	*XX*
			LILACS	*XX*	*XX*
			Cochrane Library	*XX*	*XX*
			"n"	*XX*	*XX*

Ejemplo referencial

ANEXO 12

Herramienta 8: Selección y valoración de la evidencia científica

Herramienta 8: Selección y valoración de la evidencia científica											
VCIS											
Intervención de salud	Intervención de salud individual	Estudio / Autor /Año / Referencia	Selección por título y resumen		Selección por texto completo		Evaluación de la calidad científica			
			Seleccionado	No seleccionado	Seleccionado	No seleccionado	Tipo de estudio	Instrumento aplicado	Valoración de calidad de evidencia según herramienta utilizada	Limitaciones identificadas
Promoción de la salud	Intervención de salud 1	Estudio 1								
		Estudio 2								
Prevención de la enfermedad	Intervención de salud 2	Estudio 3								
Diagnóstico	Intervención de salud 3	Estudio 4								
Tratamiento	Intervención de salud 4	Estudio 6								
Rehabilitación de la salud	Intervención de salud 5	Estudio 8								
Cuidados paliativos	Intervención de salud 6	Estudio 10								
Intervención de salud pública		Autor /Año / Referencia	Selección por título y resumen		Selección por texto completo		Tipo de estudio	Instrumento aplicado	Valoración de calidad de evidencia según herramienta utilizada	Limitaciones identificadas
			Seleccionado	No seleccionado	Seleccionado	No seleccionado				
Intervención de salud pública 1		Estudio 12								
		Estudio 13								

MINISTERIO DE SALUD
C. ALVARADO CH.

Instructivo de la herramienta 8: Selección y valoración de la evidencia científica

Esta herramienta tiene como finalidad dar soporte instrumental al proceso de selección y valoración de la evidencia científica para administrar de mejor manera la selección por título y resumen, selección por texto completo y evaluación de la calidad científica; Asimismo, para realizar la referenciación de los documentos propios de la VCIS.

El equipo elaborador en sesión y con previo conocimiento del objetivo de la actividad, posterior a la búsqueda de evidencia científica, realiza la selección por título y resumen de los estudios identificados. En este punto se verifica que se encuentre en el título y resumen los componentes de la estrategia PICO; este proceso deberá hacerse de manera pareada e independiente por los profesionales con perfil de metodología de la investigación del equipo elaborador de VCIS. En caso se encuentre disparidades en la selección, se solucionará por acuerdo, o por la participación de un tercer profesional experto en búsqueda de evidencia científica.

La herramienta está estructurada en una matriz de doble entrada, para marcar con un aspa (X) en la celda correspondiente al estudio en revisión, dentro de la columna "Selección por título y resumen" correspondiente, obteniendo 2 escenarios:

1. Seleccionado: El estudio continúa con la selección por texto completo
2. No seleccionado: El estudio se retira de las referencias identificadas

Seguidamente, se realiza la selección por texto completo de los estudios seleccionados en el paso anterior, la cual se realiza de manera pareada e independiente por los profesionales con perfil de metodología de la investigación del equipo elaborador de VCIS, teniendo en cuenta criterios de inclusión y exclusión con referencia a la población objeto de la intervención de salud, la prescripción de la intervención de salud y los desenlaces que se quieren evaluar, en términos de resultados en salud en la persona, familia y comunidad, y resultados en el proceso de atención de salud, según corresponda.

La herramienta está estructurada en una matriz de doble entrada, para marcar con un aspa (X) en la celda correspondiente al estudio en revisión, dentro de la columna "Selección por texto completo" correspondiente, obteniendo 2 escenarios:

1. Seleccionado: El estudio continúa con la evaluación de la calidad científica
2. No seleccionado: El estudio se retira de las referencias identificadas

Finalmente se realiza la valoración de calidad de evidencia científica de los estudios seleccionados por texto completo utilizando el sistema de listas de chequeo validadas internacionalmente por los desarrolladores de dichos instrumentos. A continuación, se referencia el instrumento que se puede utilizar para la valoración de la calidad científica por tipo de diseño.



TIPO DE DISEÑO	INSTRUMENTO	ACCESO
Revisiones sistemáticas	AMSTAR 2	https://www.fundacionmf.org.ar/files/144768e1fa07479c03b55626a08b7ec5.pdf

La evaluación de la calidad científica NO es un criterio de exclusión de la evidencia. Esta actividad se realiza con el objetivo de conocer el soporte de las intervenciones de salud propuestas por la evidencia científica y de esta manera acercarse a definir el nivel de confianza con el que se cuenta en la misma, en relación con los resultados reportados.

El equipo elaborador utiliza los resultados de esta herramienta para el paso 4: selección de intervenciones de salud.

Luego de cada sesión, el coordinador o algún integrante del equipo elaborador delegado, redacta el acta que contenga como mínimo lo siguiente:

1. Datos de identificación: Nombre de la reunión, fecha, hora de inicio y cierre, lugar o medio virtual, y número de sesión.
2. Participantes: nombres completos, cargos e institución de los asistentes.
3. Agenda u orden del día.
4. Desarrollo de las actividades: resumen de los temas tratados y principales aportes.
5. Registro de la Herramienta 8 (con avances o finalizada, según corresponda).
6. Acuerdos y compromisos: detalle de las decisiones, responsables y plazos.
7. Próxima fecha de reunión.
8. Firmas del coordinador, del responsable del acta y de los asistentes.

C. ALVARADO CH.

Ejemplo del registro de la Herramienta 8: Selección y valoración de la evidencia científica

Ejemplo de registro herramienta 8: Selección y valoración de la evidencia científica										
VCIS		**CÁNCER DE CUELLO UTERINO**								
Intervención de salud	**Intervención de salud individual**	**Estudio / Autor /Año / Referencia**	**Selección por título y resumen**		**Selección por texto completo**		**Evaluación de la calidad científica**			
			Seleccionado	**No seleccionado**	**Seleccionado**	**No seleccionado**	**Tipo de estudio**	**Instrumento aplicado**	**Valoración de calidad de evidencia según herramienta utilizada**	**Limitaciones identificadas**
Promoción de la salud	Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer	Efectividad de la consejería preventiva para reducir factores de riesgo asociados al cáncer: una revisión sistemática/Martínez et al./2020/Revista de Salud Pública	X		X		Revisión sistemática de ECCA	AMSTAR 2	Alta calidad de evidencia.	No se reportó con detalle la frecuencia específica de las sesiones de consejería.
		Estudio "n"		X						
Prevención de la enfermedad	*Intervención de salud 2*	*Estudio "n1"*	*X*			*X*				
Diagnóstico	*Intervención de salud 3*	*Estudio "n2"*	*X*		*X*		*XX*	*XX*	*XX*	*XX*
	Intervención de salud 4	*Estudio "n3"*	*X*			*X*				
Tratamiento	*Intervención de salud 5*	*Estudio "n4"*	*X*		*X*		*XX*	*XX*	*XX*	*XX*
	Intervención de salud 6	*Estudio "n5"*		*X*						
Rehabilitación de la salud	*Intervención de salud 7*	*Estudio "n6"*		*X*						
Cuidados paliativos	*Intervención de salud 8*	*Estudio "n7"*	*X*		*X*		*XX*	*XX*	*XX*	*XX*

C. ALVARADO CH.

Intervención de salud pública	Autor /Año / Referencia	Selección por título y resumen		Selección por texto completo		Tipo de estudio	Instrumento aplicado	Valoración de calidad de evidencia según herramienta utilizada	Limitaciones identificadas
		Seleccionado	No seleccionado	Seleccionado	No seleccionado				
Promover ambientes 100% libres de humo	Asociación entre políticas de ambientes libres de humo y la reducción de riesgos de cáncer relacionados con el tabaco, incluido el cáncer de cuello uterino/López et al./2021/Journal of Oncology Prevention	X		X		Revisión sistemática	AMSTAR 2	Moderada calidad de evidencia	Algunos datos sobre la exposición al humo fueron auto informados por los participantes, lo que podría introducir sesgos leves.
Intervención de salud pública "n"	*XX*	*X*			*X*				

C. ALVARADO CH.

Ejemplo referencial

ANEXO 13

Criterios para la incorporación excepcional de intervenciones de salud

I. Identificación de la intervención de salud.

a. VCIS que se elabora: *Coloque el nombre de la Vía de Cuidado Integral en Salud que se elabora.*

b. Nombre de la Intervención de salud preseleccionada: *Coloque el nombre de la intervención de salud preseleccionada que no cumple con los criterios de selección de GPC (herramienta 5) ni con soporte según pauta de revisión de la literatura científica, pero que existe consenso para su incorporación en la VCIS.*

c. Contexto de la Decisión: *Breve descripción de la situación que llevó a considerar esta intervención de salud (ej. emergencia sanitaria, necesidad insatisfecha en la población, prevalencia de una patología, entre otras).*

II. Análisis de la evidencia existente

a. Detalle de las fuentes consultadas: *Coloque las fuentes consultadas para soportar la intervención de salud, como, por ejemplo: literatura científica, literatura gris, recomendaciones de organismos internacionales, documentos normativos nacionales, entre otros.*

b. Sustento de investigaciones o experiencias locales: *Coloque el resultado de la revisión, por ejemplo: se identificaron experiencias locales sin validación científica formal, entre otros.*

III. Fundamento técnico del consenso

Coloque la argumentación técnica que respalda la inclusión de la intervención de salud, sustentada en criterios como razonamiento clínico, pertinencia epidemiológica, experiencia en el territorio, interculturalidad, aceptabilidad social, viabilidad operativa u otro criterio técnico relevante.

IV. Consenso técnico

a. Lista de participantes que intervinieron en la toma de decisión, con nombres completos, cargos e instituciones que representan, según corresponda.

b. Fecha y modalidad de la reunión.

c. Firma del coordinador del equipo elaborador y de los integrantes que intervinieron en la toma de decisión.



ANEXO 14

Herramienta 9: Calificación y selección de intervenciones de salud

Herramienta 9: Calificación y selección de intervenciones de salud												
VCIS												
Intervención de salud	**Intervención de salud individual**	**Criterio de calificación**	**Integrante Equipo Elaborador 1**	**Integrante Equipo Elaborador 2**	**Integrante Equipo Elaborador 3**	**Integrante Equipo Elaborador 4**	**Integrante Equipo Elaborador 5**	**Integrante Equipo Elaborador "n"**	**Valor Mediana**	**Intervención de salud seleccionada**	
										Si	**No**
Promoción de la salud	Intervención de salud individual 1	Evidencia y calidad de la evidencia									
		Balance riesgo/beneficio									
		Costo/beneficio									
		Equidad									
Prevención de la enfermedad	Intervención de salud individual 2	Evidencia y calidad de la evidencia									
		Balance riesgo/beneficio									
		Costo/beneficio									
		Equidad									
Diagnóstico	Intervención de salud individual 3	Evidencia y calidad de la evidencia									
		Balance riesgo/beneficio									
		Costo/beneficio									
		Equidad									

C. ALVARADO CH.

Tratamiento	Intervención de salud individual 4	Evidencia y calidad de la evidencia									
		Balance riesgo/beneficio									
		Costo/beneficio									
		Equidad									
Rehabilitación de la salud	Intervención de salud individual 5	Evidencia y calidad de la evidencia									
		Balance riesgo/beneficio									
		Costo/beneficio									
		Equidad									
Cuidados paliativos	Intervención de salud individual 6	Evidencia y calidad de la evidencia									
		Balance riesgo/beneficio									
		Costo/beneficio									
		Equidad									
Intervención de salud pública		**Criterio de calificación**	**Integrante Equipo Elaborador 1**	**Integrante Equipo Elaborador 2**	**Integrante Equipo Elaborador 3**	**Integrante Equipo Elaborador 4**	**Integrante Equipo Elaborador 5**	**Integrante Equipo Elaborador "n"**	**Valor Mediana**	**Intervención de salud seleccionada**	
										Si	**No**
Intervención de salud pública 1		Evidencia y calidad de la evidencia									
		Balance riesgo/beneficio									
		Costo/beneficio									
		Equidad									
Intervención de salud pública n		Evidencia y calidad de la evidencia									
		Balance riesgo/beneficio									
		Costo/beneficio									
		Equidad									

C. ALVARADO C.

Instructivo de la herramienta 9: Calificación y selección de intervenciones de salud

Esta herramienta tiene como finalidad dar soporte instrumental al proceso de calificación y selección de las intervenciones de salud de la VCIS. La herramienta está estructurada en base a cuatro criterios para la selección: Evidencia y calidad de la evidencia, Balance y riesgo/beneficio, Costo/beneficio y Equidad de la intervención de salud.

Las intervenciones de salud que son valoradas con esta herramienta son las siguientes:

- Intervención de salud identificada en GPC internacional que cumple con la puntuación establecida para el AGREE II (según herramienta 5).
- Intervención de salud identificada en GPC de Hospitales Nacionales (Perú) que cumple con la puntuación establecida para el AGREE II (según herramienta 5).
- Intervención de salud incluida en la revisión de literatura científica (según herramienta 8).
- Intervención de salud basada en otro tipo de evidencia que cuenta con consenso para su incorporación en la VCIS (Anexo 13).

Cada integrante del equipo elaborador en sesión, con previo conocimiento del objetivo de la actividad y en base a su experiencia realiza una evaluación individual a las intervenciones de salud a partir de cuatro criterios:

- **Evidencia y calidad de la evidencia:** Consiste en la existencia de evidencia científica sólida y de alta calidad.

- **Balance riesgo/beneficio de la intervención de salud:** Consiste en el equilibrio favorable entre el potencial de mejora en la salud del paciente y la probabilidad de efectos secundarios adversos.

- **Costo/beneficio:** Consiste en la relación entre los costos de la intervención de salud y sus beneficios en términos de resultados clínicos y calidad de vida.

- **Equidad:** Consiste en la garantía de que la implementación de la intervención de salud reduce las desigualdades en el acceso a los servicios de salud.

C. ALVARADO CH.

Cada integrante realiza una valoración individual de las intervenciones de salud teniendo en cuenta los criterios precitados, utilizando una escala de calificación tipo Likert, donde "1" corresponde a completamente en desacuerdo y "5" a completamente de acuerdo.

1	2	3	4	5
Completamente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni en desacuerdo ni de acuerdo	De acuerdo	Completamente de acuerdo

La selección de las intervenciones de salud se realiza a partir del cálculo de las medianas obtenidas de los puntajes asignados en la calificación.

Tabla de criterios de calificación para selección de intervenciones de salud			
Intervención de salud		**Criterios**	**Mediana**
Intervenciones de salud individual	Promoción de la salud	Evidencia y calidad de la evidencia	>2
		Balance riesgo/seguridad	>4
		Costo/beneficio	>4
		Equidad	5
	Prevención de la enfermedad	Evidencia y calidad de la evidencia	>4
		Balance riesgo/seguridad	5

		Costo/beneficio	5
		Equidad	5
	Diagnóstico	Evidencia y calidad de la evidencia	5
		Balance riesgo/seguridad	5
		Costo/beneficio	5
		Equidad	5
	Tratamiento	Evidencia y calidad de la evidencia	5
		Balance riesgo/seguridad	5
		Costo/beneficio	5
		Equidad	5
	Rehabilitación de la salud	Evidencia y calidad de la evidencia	5
		Balance riesgo/seguridad	5
		Costo/beneficio	5
		Equidad	5
	Cuidados paliativos	Evidencia y calidad de la evidencia	5
		Balance riesgo/seguridad	5
		Costo/beneficio	5
		Equidad	5
Intervenciones de salud pública		Evidencia y calidad de la evidencia	>2
		Balance riesgo/seguridad	>4
		Costo/beneficio	>4
		Equidad	5

Las intervenciones de salud que no cumplan con los criterios de calificación establecidos no serán seleccionadas.

Una vez finalizado el paso de selección de intervenciones de salud, no se incorporan nuevas intervenciones de salud y se mantienen únicamente las intervenciones de salud seleccionadas para los siguientes pasos.

Luego de cada sesión, el coordinador o algún integrante del equipo elaborador delegado, redacta el acta que contenga como mínimo lo siguiente:

C. ALVARADO CH.

1. Datos de identificación: Nombre de la reunión, fecha, hora de inicio y cierre, lugar o medio virtual, y número de sesión.
2. Participantes: nombres completos, cargos e institución de los asistentes.
3. Agenda u orden del día.
4. Desarrollo de las actividades: resumen de los temas tratados y principales aportes.
5. Registro de la Herramienta 9 (con avances o finalizada, según corresponda).
6. Acuerdos y compromisos: detalle de las decisiones, responsables y plazos.
7. Próxima fecha de reunión.
8. Firmas del coordinador, del responsable del acta y de los asistentes.

Ejemplo del registro de la Herramienta 9: Calificación y selección de intervenciones de salud

Ejemplo de registro herramienta 9: Calificación y selección de intervenciones de salud												
VCIS		**CÁNCER DE CUELLO UTERINO**										
Intervención de salud	**Intervención de salud individual**	**Criterio de calificación**	**Integrante Equipo Elaborador 1**	**Integrante Equipo Elaborador 2**	**Integrante Equipo Elaborador 3**	**Integrante Equipo Elaborador 4**	**Integrante Equipo Elaborador 5**	**Integrante Equipo Elaborador "n"**	**Valor Mediana**	**Intervención seleccionada**	
										Si	**No**
Promoción de la salud	Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer	Evidencia y calidad de la evidencia	5	5	5	5	5	4	**5**	X	
		Balance riesgo/seguridad	5	5	5	5	5	5	**5**		
		Costo/beneficio	5	5	5	5	5	5	**5**		
		Equidad	5	5	5	5	5	5	**5**		
	Intervención de salud individual "n"	*Evidencia y calidad de la evidencia*	*3*	*2*	*3*	*2*	*3*	*2*	***2.5***		*X*
		Balance riesgo/seguridad	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	***2***		
		Costo/beneficio	*1*	*3*	*1*	*3*	*1*	*3*	***2***		
		Equidad	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	***3***		
Prevención de la enfermedad	*Intervención de salud individual "n1"*	*Evidencia y calidad de la evidencia*	*4*	*5*	*5*	*5*	*4*	*5*	***5***	*X*	
		Balance riesgo/seguridad	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	***5***		
		Costo/beneficio	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	***5***		

C. ALVARADO CH.

		Equidad	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	***5***		
Diagnóstico	*Intervención de salud individual "n2"*	*Evidencia y calidad de la evidencia*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	***5***		X
		Balance riesgo/seguridad	*4*	*4*	*4*	*5*	*5*	*5*	***4.5***		
		Costo/beneficio	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	***5***		
		Equidad	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	***5***		
Tratamiento	*Intervención de salud individual n3*	*Evidencia y calidad de la evidencia*	*3*	*5*	*5*	*5*	*4*	*5*	***5***	*X*	
		Balance riesgo/seguridad	*5*	*5*	*5*	*5*	*4*	*4*	***5***		
		Costo/beneficio	*5*	*5*	*5*	*5*	*4*	*4*	***5***		
		Equidad	*5*	*4*	*5*	*5*	*4*	*5*	***5***		
Rehabilitación de la salud	*Intervención de salud individual n4*	*Evidencia y calidad de la evidencia*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	***5***	*X*	
		Balance riesgo/seguridad	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	***5***		
		Costo/beneficio	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	***5***		
		Equidad	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	***5***		
Cuidados paliativos	*Intervención de salud individual n5*	*Evidencia y calidad de la evidencia*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	***5***	*X*	
		Balance riesgo/seguridad	*4*	*4*	*5*	*5*	*5*	*5*	***5***		
		Costo/beneficio	*4*	*4*	*5*	*5*	*5*	*5*	***5***		
		Equidad	*3*	*4*	*4*	*4*	*4*	*3*	***4***		
Intervención de salud pública		**Criterio de calificación**	**Integrante Equipo Elaborador 1**	**Integrante Equipo Elaborador 2**	**Integrante Equipo Elaborador 3**	**Integrante Equipo Elaborador 4**	**Integrante Equipo Elaborador 5**	**Integrante Equipo Elaborador "n"**	**Valor Mediana**	**Intervención seleccionada**	
										Si	**No**
Promover ambientes 100% libres de humo		Evidencia y calidad de la evidencia	5	5	5	5	5	5	**5**	X	
		Balance riesgo/seguridad	5	5	5	5	5	5	**5**		

C. ALVARADO CH.

	Costo/beneficio	5	5	5	5	5	5	X		
	Equidad	5	5	5	5	5	5	X		
Intervención de salud pública 1	*Evidencia y calidad de la evidencia*	*3*	*3*	*4*	*4*	*3*	*3*	***3***	*X*	
	Balance riesgo/seguridad	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	***5***		
	Costo/beneficio	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	***5***		
	Equidad	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	***5***		
Intervención de salud pública "n1"	*Evidencia y calidad de la evidencia*	*3*	*2*	*2*	*2*	*3*	*3*	***2.5***		*X*
	Balance riesgo/seguridad	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	***4***		
	Costo/beneficio	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	***2***		
	Equidad	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	***4***		

MINISTERIO DE SALUD
C. ALVARADO CH.

Ejemplo referencial

ANEXO 15

Herramienta 10: Identificación y caracterización de los resultados esperados

Identificación y caracterización de los resultados esperados										
VCIS:										
Intervención de salud	**Intervención de salud individual**	**Descripción de la intervención de salud**	**Resultado Esperado**	**Hito**	**Indicador**	**Meta**	**Fórmula de cálculo del indicador**	**Fuente del numerador**	**Fuente del denominador**	**Responsable del Indicador**
Promoción de la salud	Intervención de salud 1									
	Intervención de salud 2									
Prevención de la	Intervención de salud 3									
enfermedad	Intervención de salud 4									
Diagnóstico	Intervención de salud 5									
Tratamiento	Intervención de salud 7									
Cuidados paliativos	Intervención de salud 9									
Rehabilitación de la salud	Intervención de salud 10									
Intervención de Salud pública		**Descripción de la intervención de salud**	**Resultado Esperado**	**Hito**	**Indicador**	**Meta**	**Fórmula de cálculo del indicador**	**Fuente del numerador**	**Fuente del denominador**	**Responsable del Indicador**
Intervención de salud 11										
Intervención de salud 12										
Intervención de salud X										

Instructivo de la herramienta 10: Identificación y caracterización de los resultados esperados

Esta herramienta tiene como finalidad dar soporte instrumental a la identificación y caracterización de los resultados esperados producto de las intervenciones de salud seleccionadas previamente para la VCIS que se elabora.

El resultado esperado corresponde al efecto deseado en la persona, familia y comunidad como consecuencia de la implementación de las intervenciones de salud individual y salud pública. Teniendo en consideración los alcances en los cambios esperados los resultados pueden ser:

- **De resultado final o impacto**: Son los cambios esperados en la persona, familia y comunidad atribuidos al conjunto de intervenciones de salud de la VCIS y que se logran a partir de más de un resultado intermedio y generalmente son a largo plazo.

- **De resultado intermedio:** Son los cambios esperados en la persona, familia y comunidad atribuidos a la provisión de una o varias intervenciones de salud contempladas en la VCIS y que pueden ser logrados en un corto o mediano plazo.

- **Resultados en calidad en la prestación de servicios de salud:** Consiste en acciones sistemáticas y continuas que llevan a una mejora medible en los servicios de salud y el estado de salud de los grupos de riesgo o pacientes específicos.

- **Resultados en reducción de la inequidad en salud:** Se define como la reducción significativa de los gradientes en salud en las poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Los hitos corresponden a logros significativos que marcan momentos trazadores en el proceso de implementación de la VCIS y están vinculados al logro de los resultados esperados. Los hitos recogen una o varias intervenciones de salud y pueden referirse a aspectos como coberturas, accesibilidad, pertinencia técnica y cultural, oportunidad, entre otros.

Para la formulación de los hitos el equipo elaborador tiene en cuenta las siguientes características:

- **Medible**: Los hitos deben ser cuantificables o medibles a través de un indicador.
- **Viable:** Las fuentes para su medición deben estar incorporadas en los sistemas de información existentes, o debe ser factible de gestionarla.
- **Pertinente**: Debe ser relevante en el cuidado integral de salud de la persona, familia y comunidad.
- **Interdisciplinario**: Debe tener en cuenta las competencias de los actores del Sistema Nacional de Salud y actores de otros sectores.
- **Consistencia científica**: Debe estar alineado con las mejores prácticas y evidencia científica disponible.
- **Alineado con metas de la Política Nacional en Salud:** Debe contribuir con los objetivos de la Política Nacional Multisectorial de Salud de manera coherente.

En caso más de una intervención de salud se correspondan con un mismo resultado esperado y/o hito, el equipo puede agrupar las intervenciones de salud.

Para todos y cada uno de los hitos en lo posible obtener indicadores, los cuales en función al tipo de dato que mide son:

- **Indicadores de estructura:** Evalúan los elementos y recursos organizativos, físicos y humanos que están disponibles para brindar servicios de salud.

- **Indicadores de proceso:** Evalúan si se están siguiendo los procedimientos adecuados y se están cumpliendo los estándares clínicos. Los indicadores de proceso se centran en el cómo se brinda la atención.

- **Indicadores de resultado:** Refleja lo que se obtiene al prestar el servicio, generalmente en términos de cambios o efectos en la salud y satisfacción del usuario.

La formulación de las metas se realiza para cada indicador la cual debe ser cuantificable y coherente con las prioridades de salud. Las metas deben ser desafiantes pero alcanzables, basadas en la situación actual y los recursos disponibles, así mismo debe ser medible con los sistemas de información actuales. Debe especificar el plazo para alcanzar cada meta.

Para la fórmula de cálculo del indicador utilice la fórmula matemática de fracción (numerador/denominador). Defina claramente qué representa el numerador y el denominador, si es necesario especifique las unidades de medida por ejemplo porcentaje, tasa por 100,000 habitantes, etc. Si el cálculo requiere pasos adicionales como multiplicar por 100 para obtener un porcentaje, inclúyalos después de la fracción.

Especifique claramente la fuente para el numerador y denominador, deben ser fuentes oficiales de información y encontrarse disponibles. En caso de ser necesaria la gestión de una nueva fuente de información considere la trazabilidad que incluye el método de recolección de datos, responsables de la recopilación, sistema de almacenamiento y gestión de la información.

Luego de cada sesión, el coordinador o algún integrante del equipo elaborador delegado, redacta el acta que contenga como mínimo lo siguiente:

1. Datos de identificación: Nombre de la reunión, fecha, hora de inicio y cierre, lugar o medio virtual, y número de sesión.
2. Participantes: nombres completos, cargos e institución de los asistentes.
3. Agenda u orden del día.
4. Desarrollo de las actividades: resumen de los temas tratados y principales aportes.
5. Registro de la Herramienta 10 (con avances o finalizada, según corresponda).
6. Acuerdos y compromisos: detalle de las decisiones, responsables y plazos.
7. Próxima fecha de reunión.
8. Firmas del coordinador, del responsable del acta y de los asistentes.



Ejemplo del registro de la Herramienta 10: Identificación y caracterización de los resultados esperados

Ejemplo de registro Herramienta 10: Identificación y caracterización de los resultados esperados										
VCIS: SALUD MATERNA										
Intervención de salud	**Intervención de salud individual**	**Descripción de la intervención de salud**	**Resultado Esperado**	**Hito**	**Indicador**	**Meta**	**Fórmula de cálculo del indicador**	**Fuente del numerador**	**Fuente del denominador**	**Responsable del Indicador**
Promoción de la salud	Consejería/Orientación para promover prácticas saludables y prevención de enfermedades del embarazo, parto y puerperio.	Realizar consejerías/orientaciones a gestantes en temas que incluyen paternidad responsable, prevención de enfermedades en zonas endémicas y en zonas geográficas de riesgo (metales pesados), fortalecimiento del cuidado psicoafectivo y en salud mental. y reconocimientos de riesgos durante el embarazo, parto y puerperio.	Gestantes con consejerías/orientación sobre prácticas saludables, riesgos y prevención enfermedades.	Consejerías/ orientaciones para promover una gestación saludable y prevenir la exposición a riesgos.	Porcentaje de gestantes que reciben al menos 2 consejerías para promover prácticas saludables y prevención de enfermedades en el segundo y tercer trimestre del embarazo.	Lograr al 2026 que el 80% de las gestantes asignadas a la RIS programadas por prioridad para visitas domiciliarias se les brinde al menos dos consejerías sobre prácticas saludables y prevención de enfermedades.	(Número de gestantes que reciben al menos 2 consejerías para promover prácticas saludables y prevención de enfermedades durante la gestación/ Total de gestantes asignadas a la RIS programadas por prioridad para visitas domiciliarias) * 100.	Registro HIS	Registro de población asignada /REUNIS	Gestores de la RIS
	Intervención de salud individual 1	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*
Prevención de la enfermedad	*Intervención de salud individual 2*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*
	Intervención de salud individual 3	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*
Diagnóstico	*Intervención de salud individual 4*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*

C. ALVARADO CH.

Tratamiento	*Intervención de salud individual 6*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*
Cuidados paliativos	*Intervención de salud individual 8*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*
Rehabilitación de la salud	*Intervención de salud individual 9*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*
Intervención de Salud pública		**Descripción de la intervención de salud**	**Resultado Esperado**	**Hito**	**Indicador**	**Meta**	**Fórmula de cálculo del indicador**	**Fuente del numerador**	**Fuente del denominador**	**Responsable del Indicador**
Fortalecimiento de la vigilancia Epidemiológica de la Morbilidad Materna Extrema y Mortalidad Materna.		* Fortalecer el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extrema y Muerte Materna, incluye: - Registro y notificación inmediata de toda muerte materna al CDC - Registro y reporte de todos los casos de morbilidad materna extrema según las definiciones y normas vigentes. - Análisis y seguimiento de los casos para activar acciones correctivas en los servicios de salud. - Fortalecimiento de la capacidad técnica de los actores para la investigación, el análisis de información y toma de decisiones. - Gestionar la interoperabilidad del sistema de	Vigilancia de la Morbilidad Materna Extrema y de la Mortalidad Materna, fortalecida	Notificación de la MME, mortalidad materna y mortalidad.	Razón de Morbilidad Materna por 10.000 nacidos vivos (RMM) Razón.	Llegar a 8 por 1,000 nacidos vivos (80 por 10,000).	(Razón de Morbilidad Materna del año finalizado - Razón de Mortalidad Materna del año previo).	Sistema de Información de morbilidad materna	Sistema Nacional de Vigilancia de la Mortalidad Materna (REUNIS), gestionado por la Dirección General de Epidemiología del MINSA.	Gestores de la RIS CDC Perú realiza la vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna.

C. ALVARADO CH.

	información para articulación interinstitucional por diferentes niveles de gestión y de gobierno.								
Intervención de salud 12	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*
Intervención de salud X	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*

Ejemplo referencial

MINISTERIO DE SALUD Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

ANEXO 16

Herramienta 11: Matriz de Intervenciones de Salud

A) Caracterización de la condición de salud

PERÚ Ministerio de Salud	**Matriz de Intervenciones de Salud - Caracterización de la condición de salud**
Nombre de la VCIS	*Escriba el nombre de la VCIS que se elabora. Si existen siglas o términos alternativos, inclúyalos entre paréntesis.*
Descripción de la condición de salud	*Describa las características individuales y poblacionales de la condición de salud que se aborda, mencione brevemente los grupos poblacionales más susceptibles o vulnerables, orientándolo a las posibles consecuencias de salud que puede generar en caso de no intervenir.*
Caracterización epidemiológica en el país	*identifique incidencias, prevalencias, tasas de mortalidad o letalidad; y todos aquellos datos relevantes a nivel nacional. Mencione la fuente y el año de los datos presentados.*
Identificación de ubicación geográfica de mayores casos de la condición de salud (si las hay)	*Registre los datos de Incidencia, mortalidad y prevalencia de la condición de salud a nivel regional o local según corresponda. Si es posible, incluya un mapa o gráfico que ilustre la distribución geográfica y analice brevemente los factores locales que puedan explicar las variaciones geográficas observadas.*

MINISTERIO DE SALUD
C. ALVARADO CH.

B) Soporte de la Evidencia Científica

PERÚ | Ministerio de Salud

Matriz de Intervenciones de Salud - Soporte de Evidencia Científica y/o Documento Normativo

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Intervención de salud	**Identificación numérica y secuencial de las intervenciones de salud (ID)**	**Intervención de salud individual**	**Evidencia de GPC o DN (Si o No) Si la respuesta es Si, no registre las celdas F y G.**	**Nombre del Documento normativo o GPC**	**Palabras Clave**	**Bases**	**Referencia bibliográfica**	**Enlace del documento (si está virtual)**	**¿Intervención planteada por el equipo elaborador? (solo cuando se identificó otro tipo de evidencia)**
Promoción de la salud	ID-001	Intervención de salud 1							
	ID-002	Intervención de salud 2							
Prevención de la enfermedad	ID-003	Intervención de salud 3							
Diagnóstico	ID-005	Intervención de salud 5							
	ID-006	Intervención de salud 6							
Tratamiento	ID-007	Intervención de salud 7							
Rehabilitación de la salud	ID-008	Intervención de salud 8							
Cuidados paliativos	ID-00N	Intervención de salud N							
Identificación numérica y secuencial de las intervenciones (ID)		**Intervención de salud pública**	**Evidencia de GPC o DN (Si o No) Si la respuesta es Si, no registre las celdas F y G.**	**Nombre del Documento normativo o GPC**	**Palabras Clave**	**Bases**	**Referencia bibliográfica**	**Enlace del documento (si está virtual)**	**¿Intervención planteada por el equipo elaborador? (solo cuando se identificó otro tipo de evidencia)**
ID-009		Intervención de salud 9							
ID-00N		Intervención de salud "n"							

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

C) Intervenciones de Salud

PERÚ | Ministerio de Salud

Matriz de Intervenciones de Salud – Intervenciones de Salud

Intervención de salud	ID	Intervención de Salud individual	Descripción de la intervención de salud	RHUS que ejecuta la actividad (Quién)	Escenario de cuidado (Dónde)	E.S. donde se brinda la intervención de salud	Mecanismo de entrega (Cómo)				
							Atención o Decisión	Tipo de Oferta (Fija, móvil y/o telesalud)	Población objetivo	Periodicidad de la intervención	Destinatario (persona)
Promoción de la salud	ID-001	Intervención de salud 1									
	ID-002	Intervención de salud 2									
Prevención de la enfermedad	ID-003	Intervención de salud 3									
	ID-004	Intervención de salud 4									
Diagnóstico	ID-005	Intervención de salud 5									
	ID-006	Intervención de salud 6									
Tratamiento	ID-007	Intervención de salud 7									
	ID-008	Intervención de salud 8									
Rehabilitación de la salud	ID-009	Intervención de salud 9									
	ID-010	Intervención de salud 10									
Cuidados paliativos	ID-011	Intervención de salud 11									
	ID-00N	Intervención de salud n									

ID	Intervención de salud pública	Descripción de la intervención de salud	RHUS que ejecuta la actividad (Quién)	Escenario de cuidado (Dónde)	Mecanismo de entrega (cómo)					Responsable intersectorial, intergubernamental o interinstitucional (si corresponde)
					Atención o decisión	Tipo de Oferta (Fija, móvil y/o telesalud)	Población objetivo	Periodicidad de la intervención	Destinatario (familia y/o comunidad	
ID-00X	Intervención de salud X									
ID-00Y	Intervención de salud Y									
ID-00T	Intervención de salud T									

C. ALVARADO CH.

D) Identificación y caracterización de los resultados esperados

Matriz de Intervenciones de Salud – Identificación y caracterización de los resultados esperados

Identificación y caracterización de los resultados esperados

Intervención de salud	ID	Intervención de salud individual	Descripción de la intervención de salud	Resultado esperado	Hito	Indicador	Meta	Fórmula de cálculo del indicador	Fuente del numerador	Fuente del denominador	Responsable del Indicador
Promoción de la salud	ID-001	Intervención de salud 1									
	ID-002	Intervención de salud 2									
Prevención de la enfermedad	ID-003	Intervención de salud 3									
	ID-004	Intervención de salud 4									
Diagnóstico	ID-005	Intervención de salud 5									
	ID-006	Intervención de salud 6									
Tratamiento	ID-007	Intervención de salud 7									
Cuidados paliativos	ID-008	Intervención de salud 8									
Rehabilitación de la salud	ID-009	Intervención de salud 9									
ID	**Intervención de Salud pública**		**Descripción de la intervención de salud**	**Resultado esperado**	**Hito**	**Indicador**	**Meta**	**Fórmula de cálculo del indicador**	**Fuente del numerador**	**Fuente del denominador**	**Responsable del Indicador**
ID-010	Intervención de salud 11										
ID-011	Intervención de salud 12										
ID-012	Intervención de salud x										

C. ALVARADO CH.

E) Barreras y Facilitadores para la Implementación

PERÚ | Ministerio de Salud

Matriz de Intervenciones de Salud - Barreras y Facilitadores de la Implementación

Intervención de salud	ID	Intervención de salud individual	Intervención de salud en ejecución (Si o No)	Financiamiento (Indique la categoría presupuestal y las diferentes fuentes de financiamiento relacionadas a la intervención de salud)	Barreras para la implementación	Facilitadores de la implementación (Coloque propuestas para abordar las barreras)
Promoción de la salud	ID-001	Intervención de salud 1				
	ID-002	Intervención de salud 2				
Prevención de la enfermedad	ID-003	Intervención de salud 3				
	ID-004	Intervención de salud 4				
Diagnóstico	ID-005	Intervención de salud 5				
	ID-006	Intervención de salud 6				
Tratamiento	ID-007	Intervención de salud 7				
	ID-008	Intervención de salud 8				
Rehabilitación de la salud	ID-009	Intervención de salud 9				
Cuidados paliativos	ID-00N	Intervención de salud N				
ID		**Intervención de salud pública**	**Intervención de salud en ejecución (Si o No)**	**Financiamiento (Indique la categoría presupuestal y las diferentes fuentes de financiamiento relacionadas a la intervención de salud)**	**Barreras para la implementación**	**Facilitadores de la implementación (Coloque propuestas para abordar las barreras)**
ID-00X		Intervención de salud X				
ID-00Z		Intervención de salud Z				

C. ALVARADO CH.

Instructivo de la herramienta 11: Matriz de intervenciones de salud

Esta herramienta tiene como finalidad dar soporte instrumental al proceso de elaboración de la Matriz de intervenciones de salud de la VCIS en relación con la condición de salud que se aborda.

El equipo elaborador en sesión y con previo conocimiento del objetivo de la actividad, registra las intervenciones de salud definitivas, que resultan de los pasos anteriores, en la matriz de intervenciones de salud. La matriz de intervenciones de salud está constituida por cinco componentes:

1. **Componente 1: Caracterización de la condición de salud:** Consiste en describir la condición de salud que se aborda con la VCIS en términos de sus características individuales, familiares y comunitarias y su impacto en el sistema de salud; incluyendo incidencias, prevalencias, tasas de mortalidad o letalidad. Se deben incluir todos los datos relevantes que contextualicen y dimensionen la necesidad de intervención sobre dicha condición de salud.

2. **Componente 2: Soporte de evidencia científica y/o Documento Normativo:** Corresponde a enunciar por cada intervención de salud la evidencia científica; ya sea por la existencia de GPC o documento normativo de cumplimiento obligatorio que aborde el alcance de la VCIS o las referencias bibliográficas que seleccionó para proponer la intervención de la VCIS considerando la revisión de la literatura científica.

3. **Componente 3: Intervenciones de salud**: Corresponde a caracterizar las intervenciones de salud en términos de su descripción (quién, dónde y cómo), y actores intersectoriales responsables de su ejecución.

4. **Componente 4: Identificación y caracterización de los resultados esperados:** Corresponde a la formulación de los resultados esperados, metas, hitos e indicadores de las intervenciones de salud seleccionadas a los cuales se realizará medición, seguimiento y evaluación.

5. **Componente 5: Barreras y facilitadores para la implementación:** Corresponde a describir los posibles factores facilitadores y las barreras para la implementación de la VCIS en aspectos operativos, financieros, de gestión en salud, de gestión del cambio, entre otros.

MINISTERIO DE SALUD
C. ALVARADO CH.

Para el componente 1: Caracterización de la condición de salud

- **Nombre de la VCIS:** Escriba el nombre de la VCIS que se elabora. Si existen siglas o términos alternativos, inclúyalos entre paréntesis.

- **Descripción de la condición de salud:** Describa las características individuales y poblacionales de la condición de salud que se aborda, mencione brevemente los grupos poblacionales más susceptibles o vulnerables, orientándolo a las posibles consecuencias de salud que puede generar en caso de no intervenir. Se recomienda citar según el estilo Vancouver.

- **Caracterización epidemiológica en el país:** identifique incidencias, prevalencias, tasas de mortalidad o letalidad; y todos aquellos datos relevantes a nivel nacional. Mencione la fuente y el año de los datos presentados.

- **Identificación de la ubicación geográfica de mayores casos de la condición de salud:** Registre los datos de incidencia, mortalidad y prevalencia de la condición de salud a nivel regional o local según corresponda. Si es posible, incluya un mapa o gráfico que ilustre la distribución geográfica y analice brevemente los factores locales que puedan explicar las variaciones geográficas observadas.

Para el componente 2: Soporte de la Evidencia Científica y/o Documento Normativo

- **Identificación numérica y secuencial de las intervenciones (ID):** Asigne a cada intervención de salud definitiva un número único y secuencial. Ejemplo: ID-001, ID-002, etc. Use este identificador para referirse a la intervención de salud en todos los documentos relacionados, en adelante.

- **Intervención de Salud:** Registre las intervenciones de salud definitivas resultantes de los pasos previos en la elaboración de la VCIS. Ubique claramente si la intervención es de salud individual o de salud pública. No añada nuevas intervenciones de salud.

- **Evidencia de GPC o Documento Normativo:** Por cada intervención de salud cite la GPC o documento normativo que soporta su incorporación en la VCIS en términos de evidencia científica u obligatoriedad según corresponda.

- **Nombre del Documento normativo o GPC:** Registre el nombre de la evidencia científica, documento normativo o Guía de Práctica Clínica (GPC) utilizada.

- **Palabras Clave:** Complete esta columna **solo si no existe** una GPC o documento normativo que soporta la intervención de salud y realizó la revisión de la literatura científica. Registre las palabras utilizadas en los buscadores para encontrar la evidencia que dio lugar a la intervención de salud recomendada. Considere los insumos del paso 3: Revisión de evidencia científica o documento normativo vigente.

- **Bases:** Complete esta columna **solo si no existe** una GPC o documento normativo que soporta la intervención de salud y realizó la revisión de la literatura científica. Registre las bases de datos electrónicas en las que realizó las búsquedas para identificar publicaciones indexadas como: MEDLINE, EMBASE, LILACS, entre otras. Considere los insumos del paso 3: Revisión de evidencia científica o documento normativo vigente.



- **Referencia Bibliográfica:** Escriba la referencia bibliográfica según normas Vancouver, por cada intervención de salud.

- **Enlace del documento:** Registre el enlace de internet del documento normativo, Guía de Práctica Clínica (GPC) o evidencia científica utilizada (versión electrónica).

- **Intervención de salud planteada por el equipo elaborador:** Complete esta columna solo si la intervención de salud definitiva resulta de otro tipo de evidencia y el equipo elaborador consideró su incorporación en la VCIS, según lo establecido en el numeral 6.2.2.2.6 de la presente NTS.

Para el componente 3: Intervenciones de Salud

- **Identificación numérica y secuencial de las intervenciones (ID):** Mantenga el mismo ID asignado a cada intervención de salud en el componente 2, no asigne nuevos números.

- **Intervención de Salud:** Mantenga las intervenciones de salud registradas en el componente anterior. No añada nuevas intervenciones de salud. Estas son las intervenciones definitivas resultantes de los pasos previos en la elaboración de la VCIS.

- **Descripción de la Intervención de Salud:** Realice una breve descripción de la intervención de salud la cual contenga las actividades comprendidas, sus características incluyendo la tecnología, población objetivo, características individuales (edad, sexo y condiciones para su ejecución) y características poblacionales, según corresponda. Utilice la descripción de la intervención de salud de la herramienta 3A y 3B.

- **Recursos Humanos en Salud que ejecutan la intervención de salud.**

  Para las intervenciones de salud individual complete la información con el RHUS que brinda las intervenciones de salud seleccionadas sea médico general, médico especialista, obstetra, enfermera entre otros profesionales de la salud, consignando la especialidad y subespecialidad según corresponda, no siendo excluyentes necesariamente. Considere la herramienta 3A.

  Para las intervenciones de salud pública complete la información con los representantes de los sectores del Poder Ejecutivo, representantes del Gobierno Regional, gobiernos municipales, Gestores de la RIS, organizaciones sociales, actores sociales individuales, RHUS, entre otros, no siendo excluyentes necesariamente. Considere la herramienta 3B.

- **Escenario de Cuidado:**

  Para las intervenciones de salud individual y salud pública: Complete la información con el escenario de cuidado en donde se desarrolla la intervención de salud: Hogar, Instituciones Educativas, Centro Laboral, Establecimiento de Salud, Comunidad, entre otros. Considere las herramientas 3A y 3B.

- **Establecimiento de Salud:** Solo aplica a las intervenciones de salud individual, registre el establecimiento de salud donde se brinda la intervención de salud: E.S. del primer nivel de atención de salud de hasta 12 horas, E.S. del primer nivel de atención de salud de 24 horas, E.S. del segundo nivel de atención de salud o E.S. del tercer nivel de atención de salud.



- **Mecanismo de Entrega (cómo):** Comprende:

  a. **Atención o decisión:** Clasifique la intervención de salud como "atención" si implica una acción directa de cuidado o tratamiento a la persona, familia y comunidad, y/o como "decisión" si involucra un proceso de toma de decisiones.

  b. **Tipo de modalidad de oferta de servicios de salud:** Clasifique si la intervención de salud se brinda mediante oferta fija, oferta móvil y/o telesalud. Para las intervenciones de salud individual considere la información de la herramienta 1.

  c. **Población objetivo:** Identifique la población a la que se dirige la intervención de salud, por ejemplo: curso de vida niño, persona con diagnóstico confirmado de hipertensión, entre otros según corresponda a la naturaleza de la intervención de salud.

  d. **Periodicidad de la intervención de salud:** Enuncie el número de veces en que se hace necesario realizar la intervención de salud y el intervalo requerido entre las mismas.

  e. **Destinatario:** Identifique si la intervención de salud va dirigida a la persona, familia y/o comunidad.

- **Responsable intersectorial, intergubernamental y/o interinstitucional:** Aplica solo para las intervenciones de salud pública. Registre los actores que se consideran responsables o contribuyen en el cumplimiento de la intervención de salud.

Para el componente 4: Identificación y caracterización de los resultados esperados
La información que se registra en este componente corresponde a lo descrito en la herramienta 10 "identificación y caracterización de los resultados esperados". Mantenga el ID asignado a cada intervención de salud. No añada nueva información.

Para el componente 5: Barreras y facilitadores de la implementación

- **Identificación numérica y secuencial de las intervenciones de salud (ID):** Mantenga el mismo ID asignado a cada intervención de salud en los componentes anteriores, no asigne nuevos números.

- **Intervención de Salud:** Mantenga las intervenciones de salud registradas en el componente anterior. No añada nuevas intervenciones de salud. Estas son las intervenciones de salud definitivas resultantes de los pasos previos en la elaboración de la VCIS.

- **Intervención de salud en ejecución:** Identifique si la intervención de salud se está ejecutando actualmente o no.

- **Financiamiento:**

  - Para las intervenciones de salud individual identifique a que categoría presupuestal corresponde el financiamiento de la intervención de salud, así como las diferentes fuentes de financiamiento relacionadas.

  - Para las intervenciones de salud pública, el financiamiento debe ser identificado a nivel interinstitucional, intersectorial y/o intergubernamental según corresponda.

- **Barreras para la implementación:** Identifique para cada una de las intervenciones de salud las posibles barreras en términos de financiamiento, competencias del RHUS, rol de los actores sociales, procesos administrativos, sistema de información, brecha de RHUS, brecha de recursos tecnológicos, entre otros, según corresponda.

- **Facilitadores de la implementación:** Identifique y describa los factores clave que podrían favorecer y acelerar la implementación exitosa de cada intervención de salud. Considere aspectos como políticas públicas favorables, recursos financieros disponibles o potenciales, experiencia del RHUS, infraestructura existente, sistemas de información eficientes, colaboraciones intersectoriales, participación comunitaria, innovaciones tecnológicas aplicables, entre otras.

C. ALVARADO CH.

Luego de cada sesión, el coordinador o algún integrante del equipo elaborador delegado, redacta el acta que contenga como mínimo lo siguiente:

1. Datos de identificación: Nombre de la reunión, fecha, hora de inicio y cierre, lugar o medio virtual, y número de sesión.
2. Participantes: nombres completos, cargos e institución de los asistentes.
3. Agenda u orden del día.
4. Desarrollo de las actividades: resumen de los temas tratados y principales aportes.
5. Registro de la Herramienta 11 (con avances o finalizada, según corresponda).
6. Acuerdos y compromisos: detalle de las decisiones, responsables y plazos.
7. Próxima fecha de reunión.
8. Firmas del coordinador, del responsable del acta y de los asistentes.

Ejemplo del registro de la Herramienta 11: Matriz de Intervenciones de Salud

A) Caracterización de la condición de salud

PERÚ Ministerio de Salud	**Caracterización de la condición de salud**
Nombre de la VCIS	*VCIS CÁNCER DE CUELLO UTERINO.*
Descripción de la condición de salud	El cáncer de cuello uterino es una enfermedad que progresa lentamente desde un estado preinvasivo hasta un cáncer invasivo, proceso que puede tomar entre 10 a 30 años. La infección persistente por el virus del papiloma humano (VPH) es una condición necesaria para el desarrollo de lesiones precancerosas y su posterior progresión a cáncer de cuello uterino. La mayoría de las infecciones por VPH, que son comunes especialmente en mujeres jóvenes, tienden a resolverse espontáneamente debido a la respuesta del sistema inmunológico. Sin embargo, en casos de infecciones persistentes con tipos de VPH de alto riesgo, pueden desarrollarse displasias que, sin tratamiento, progresan a cáncer invasivo. (1-4) En la patogénesis del cáncer de cuello uterino, el VPH ingresa a las células epiteliales basales a través de micro lesiones y establece una infección que puede llevar a la transformación maligna de estas células. Este proceso se acelera en presencia de otros factores de riesgo como el inicio temprano de la actividad sexual, múltiples parejas sexuales, tabaquismo, y un sistema inmunológico debilitado, como en el caso de mujeres con VIH. (5-7) Las mujeres de bajo nivel socioeconómico también son más vulnerables debido a menores tasas de vacunación y acceso limitado a programas de detección temprana y tratamiento. Adicionalmente, factores como el uso prolongado de anticonceptivos orales y tener múltiples embarazos también incrementan el riesgo. El cáncer de cuello uterino es más prevalente en regiones con desigualdades socioeconómicas significativas, como África subsahariana, América Latina y el Caribe, donde la incidencia y mortalidad son más altas comparadas con regiones de altos ingresos. (8-9) **Referencias:** 1. National Center for Biotechnology Information. Cervical Cancer - Cancer - NCBI Bookshelf. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470260/ 2. Science Direct. Cervical Cancer: An Overview of Pathophysiology and Management. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cervical-cancer 3. Prevent Cancer Foundation. The natural history and epidemiology of HPV and cervical cáncer. Disponible en: https://www.preventcancer.org/cervical-cancer-hpv/ 4. American Academy of Family Physicians. Cervical Cancer: Evaluation and Management. Disponible en: https://www.aafp.org/dam/AAFP/documents/journals/afp/cervical-cancer.pdf

	5. Centers for Disease Control and Prevention. Natural History of HPV and Cervical Cancer. Disponible en: https://www2c.cdc.gov/podcasts/player.asp?f=8626179 6. World Health Organization. Cervical cáncer. 2022. Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer 7. American Cancer Society. Risk Factors for Cervical Cancer. 2023. Disponible en: https://www.cancer.org/cancer/cervical-cancer/causes-risks-prevention/risk-factors.html 8. Human papillomavirus vaccination and cervical cáncer risk. The BMJ. 2020. Disponible en: https://www.bmj.com/content/365/bmj.l1359 9. BMC Cancer. Socio demographic characteristics and their association with survival in women with cervical cáncer. 2020. Disponible en: https://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12885-019-5899-2Cancer Research UK. Cervical cáncer risk factors. 2022. Disponible en:https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cervical-cancer/risks-causes
Caracterización epidemiológica en el país	**Incidencia de CACU:** Según la Dirección General de Epidemiología (CDC) del Ministerio de Salud del Perú, **se reportó un total de 2161 nuevos casos** de cáncer de cuello uterino **durante el año 2023,** traduciéndose esto en una **incidencia de 12.57 casos por cada 100 000 mujeres** en el año señalado (Pob. Proyectada a 2023: 17188613 habitantes a nivel nacional). Fuente: CDC. MINSA. Extraído de: https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/sala/2023/SE52/cancer.pdf **Total de casos atendidos por cáncer de cuello uterino en el año 2023:** 41852 casos. Fuente: Repositorio Único Nacional de Información en Salud (REUNIS) 2024. https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/cancer_atenciones_atendidos.asp **Respuesta operativa para el tamizaje de cáncer de cuello uterino y tratamiento:** **Tamizaje:** • Por PAP: 255 842 pruebas realizadas; 769 casos con lesión de bajo grado; 511 con lesiones de alto grado y 398 casos con células escamosas y glandulares atípicas. • Por IVAA: 159 515 pruebas realizadas; 4550 casos positivos **Tratamiento:** • Radioterapia: 5430 casos tratados • Quimioterapia: 9040 casos tratados.

C. ALVARADO CH.

Identificación de ubicación geográfica de mayores casos de la condición de salud (si las hay)

Para el primer trimestre del año 2024, se reportaron 738 casos de cáncer de cuello uterino en el Perú. Los departamentos más afectados fueron Lima, Junín y Cajamarca, registrando el 19,24% (n=142), 12,74% (n=94) y 7,45% (n=55) del total de casos, respectivamente. La Libertad y Arequipa también presentan un alto número de casos con 54 (7,32%) y 50 (6,78%). Ancash, Lambayeque y Cusco siguen con 46 (6,23%), 39 (5,28%) y 33 (4,47%) casos respectivamente. Los departamentos menos afectados incluyen Pasco, Moquegua, Madre de Dios, San Martín y Tumbes con menos del 1% del total de casos.
Para mayor detalle se adjunta:

Departamento	Casos de Cáncer de Cérvix	% Cérvix
Lima	142	19,24%
Junín	94	12,74%
Cajamarca	55	7,45%
La libertad	54	7,32%
Arequipa	50	6,78%
Ancash	46	6,23%
Lambayeque	39	5,28%
Cusco	33	4,47%
Huánuco	31	4,20%
Ayacucho	28	3,79%
Loreto	20	2,71%
Piura	19	2,57%
Tacna	16	2,17%
Ucayali	15	2,03%
Puno	13	1,76%
Callao	11	1,49%
Amazonas	10	1,36%
Ica	10	1,36%
Apurímac	10	1,36%
Huancavelica	10	1,36%
Pasco	9	1,22%
Moquegua	8	1,08%
Madre de dios	8	1,08%
San martín	6	0,81%
Tumbes	1	0,14%
Total	738	100,00%

Fuente: CDC. MINSA. Extraído de: https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/sala/2024/SE24/cancer.pdf

Ejemplo referencial

B) Soporte de la Evidencia Científica

PERÚ | Ministerio de Salud

Matriz de Intervenciones de Salud - Soporte de Evidencia Científica y/o Documento Normativo

A	B	C	D	E	F	G	H		
Intervención de salud	**Identificación numérica y secuencial de las intervenciones de salud (ID)**	**Intervención de salud individual**	**Evidencia de GPC o DN (Si o No) Si la respuesta es Si, no registre las celdas F y G.**	**Nombre del Documento normativo o GPC**	**Palabras Clave**	**Bases**	**Referencia bibliográfica**	**Enlace del documento (si está virtual)**	**¿Intervención planteada por el equipo elaborador? (solo cuando se identificó otro tipo de evidencia)**
Promoción de la salud	ID-001	Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer	Si	Lineamientos de políticas de Promoción de la salud			MINSA. Lineamientos de políticas de Promoción de la salud en el Perú. 2017	https://minsa.gob.pe	No
	ID-002	*Intervención de salud 2*	*No*		*Health Services [MeSH]*	*MEDLINE*	*Smith J, Adams R. The impact of health services on public health outcomes. J Public Health. 2023;45(3):123-130. PubMed. PMID: 98765432. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9876532/*	*www.medline.com*	*No*
Prevención de la enfermedad	*ID-003*	*Intervención de salud 3*	*XX*		*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*
Diagnóstico	*ID-005*	*Intervención de salud 5*	*XX*		*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*

C. ALVARADO CH.

	ID-006	*Intervención de salud 6*	*XX*	*XX*		*XX*	*XX*	*XX*	*XX*
Tratamiento	*ID-007*	*Intervención de salud 7*	*XX*	*XX*		*XX*	*XX*	*XX*	*XX*
Rehabilitación de la salud	*ID-008*	*Intervención de salud 8*	*XX*	*XX*		*XX*	*XX*	*XX*	*XX*
Cuidados paliativos	*ID-00N*	*Intervención de salud N*	*XX*	*XX*		*XX*	*XX*	*XX*	*XX*
Identificación numérica y secuencial de las intervenciones (ID)		**Intervención de salud pública**	**Evidencia de GPC o DN (Si o No) Si la respuesta es Si, no registre las celdas D, E y F**	**Nombre del Documento normativo o GPC**	**Palabras Clave**	**Bases**	**Referencia bibliográfica**	**Enlace del documento (si está virtual)**	**¿Intervención planteada por el equipo elaborador? (solo cuando se identificó otro tipo de evidencia)**
ID-009		Promover ambientes 100% libres de humo	No	The impact of health services on public health outcomes	Health communication	LILACS	Smith J, Adams R. The impact of health services on public health outcomes. J Public Health. 2023;45(3):123-130. PubMed. PMID: 98765432. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/98765432/	www.lilacs.com	No
ID-00N		*Intervención de salud "n"*	*Si*					*www.lilacs.com*	*No*

Ejemplo referencial

C. ALVARADO CH.

C) Intervenciones de Salud

Matriz de Intervenciones de Salud – Intervenciones de Salud

Intervención de salud	ID	Intervención de Salud individual	Descripción de la intervención de salud	RHUS que ejecuta la actividad (Quién)	Escenario de cuidado (Dónde)	E.S. donde se brinda la intervención de salud	Mecanismo de entrega (Cómo)				
							Atención o decisión	Tipo de Oferta (Fija, móvil y/o telesalud)	Población objetivo	Periodicidad de la intervención	Destinatario (persona)
Promoción de la salud	ID-001	Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer	Intervención multidimensional que incluye consejería integral, acciones educativas, materiales informativos (escritos y/o audiovisuales) y/o actividades extramurales dirigidas a promover estilos de vida saludables; y prevenir y controlar factores de riesgo asociados con el cáncer de cuello uterino	Personal de salud capacitado en consejería preventiva (Médico cirujano, Lic. En enfermería, Obstetra, Técnico asistencial)	E.S. Hogar Centro educativo Centro Laboral Comunidad	E.S. del I NAS hasta 12 horas, E.S. del I NAS de 24 horas, E.S. del II NAS y/o E.S. del III NAS	Atención	Fija Móvil Telesalud	Población general de la RIS	Anual	Persona
	ID-002	*Intervención de salud 2*		*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*
Prevención de la enfermedad	*ID-003*	*Intervención de salud 3*		*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*
	ID-004	*Intervención de salud 4*		*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*

C. ALVARADO CH.

Diagnóstico	*ID-005*	*Intervención de salud 5*		*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	
	ID-006	*Intervención de salud 6*		*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	
	ID-008	*Intervención de salud 8*		*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	
Rehabilitación de la salud	*ID-009*	*Intervención de salud 9*		*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	
Cuidados paliativos	*ID-011*	*Intervención de salud 11*		*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	
	ID-00N	*Intervención de salud n*		*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	

ID	**Intervención de salud pública**	**Descripción de la intervención de salud**	**RHUS que ejecuta la actividad (Quién)**	**Escenario de cuidado (Dónde**	**Mecanismo de entrega (cómo)**					**Responsable intersectorial, intergubernamental o interinstitucional (si corresponde)**
					Atención o Decisión	**Tipo de Oferta (Fija, móvil y/o telesalud)**	**Población objetivo**	**Periodicidad de la intervención**	**Destinatario (familia y/o comunidad**	
ID-00X	Promover ambientes 100% libres de humo	Busca garantizar que espacios públicos, privados de acceso público y laborales cumplan con la normativa vigente sobre ambientes libres de humo de tabaco, promoviendo la salud de la población mediante acciones de sensibilización, vigilancia y cumplimiento de regulaciones.	Personal de salud capacitado (Médico cirujano, Lic. En enfermería, Obstetra, Técnico asistencial)	Comunidad Hogar Centros Laborales	Atención	Móvil	Población general de la RIS	Semestral	Comunidad	Ministerio de Trabajo Gobierno Local
ID-00Y	*Intervención de salud Y*		*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*
ID-00T	*Intervención de salud T*		*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*

Ejemplo referencial

C. ALVARADO CH.

D) Identificación y caracterización de los resultados esperados

Matriz de Intervenciones de Salud – Identificación y caracterización de los resultados esperados

				Identificación y caracterización de los resultados esperados							
Intervención de salud	**ID**	**Intervención de salud individual**	**Descripción de la intervención de salud**	**Resultado Esperado**	**Hito**	**Indicador**	**Meta**	**Fórmula de cálculo del indicador**	**Fuente del numerador**	**Fuente del denominador**	**Responsable del Indicador**
Promoción de la salud	ID-001	*El registro es igual que la herramienta 10*									
	ID-002	*Intervención de salud 2*									
Prevención de la enfermedad	*ID-003*	*Intervención de salud 3*									
Diagnóstico	*ID-005*	*Intervención de salud 5*									
Tratamiento	*ID-007*	*Intervención de salud 7*									
Cuidados paliativos	*ID-008*	*Intervención de salud 8*									
Rehabilitación de la salud	*ID-009*	*Intervención de salud 9*									
ID		**Intervención de Salud pública**	**Descripción de la intervención de salud**	**Resultado Esperado**	**Hito**	**Indicador**	**Meta**	**Fórmula de cálculo del indicador**	**Fuente del numerador**	**Fuente del denominador**	**Responsable del Indicador**
El registro es igual que la herramienta 10											
ID-010		*Intervención de salud 12*									
ID-011		*Intervención de salud X*									

C. ALVARADO CH.

E) Barreras y Facilitadores para la Implementación

PERÚ | Ministerio de Salud

Matriz de Intervenciones de Salud - Barreras y Facilitadores para la Implementación

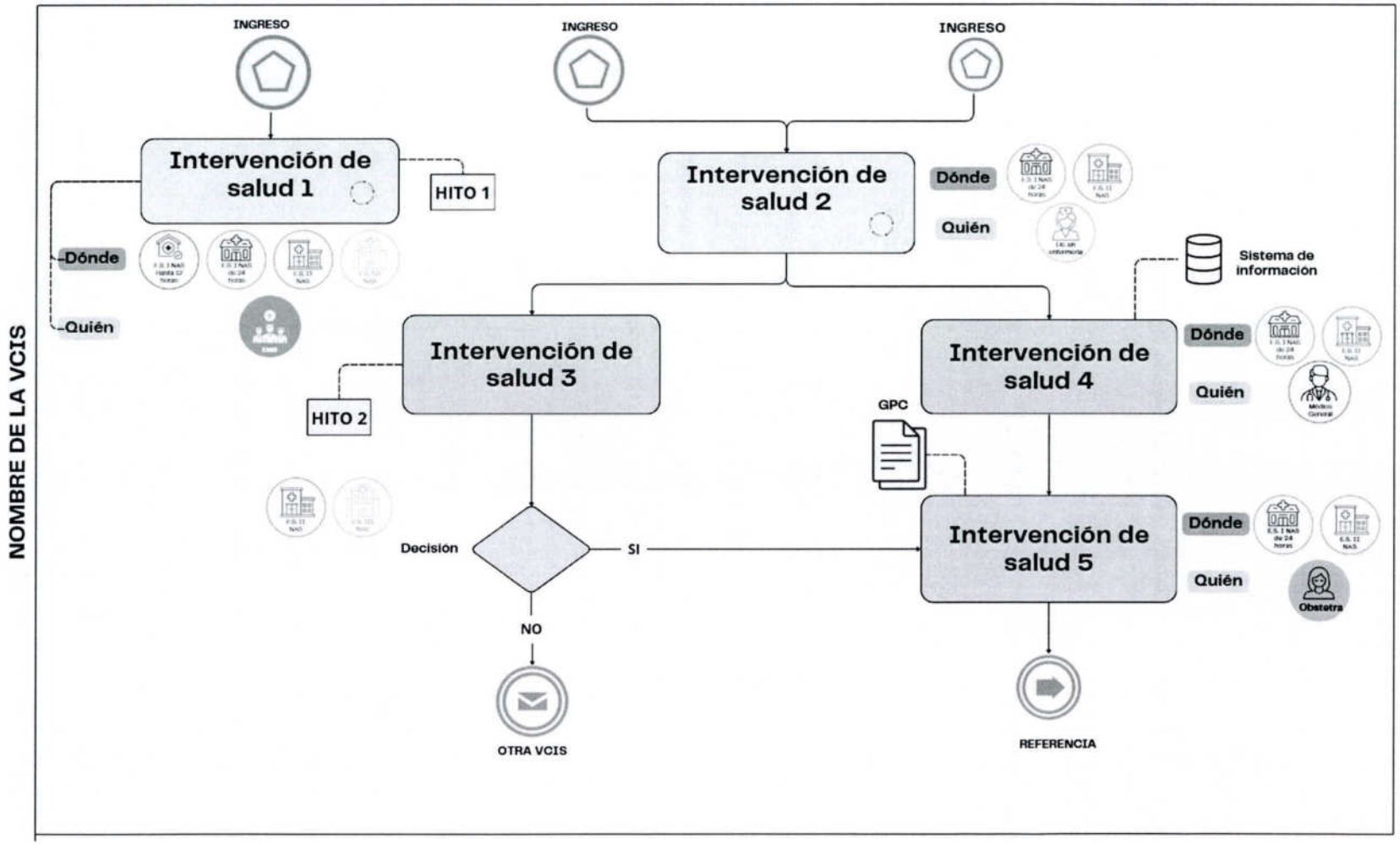
Intervención de salud	**ID**	**Intervención de salud individual**	**Intervención de salud en ejecución (Si o No)**	**Financiamiento (Indique la categoría presupuestal y las diferentes fuentes de financiamiento relacionadas a la intervención de salud)**	**Barreras para la implementación**	**Facilitadores de la implementación (Coloque propuestas para abordar las barreras)**
Promoción de la salud	ID-001	Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer	Si	PP024	Resistencia cultural. Falta de adherencia de la población a las recomendaciones.	Apoyo institucional Colaboración intersectorial Capacitación continua
Prevención de la enfermedad	*ID-003*	*Intervención de salud 3*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*
Diagnóstico	*ID-005*	*Intervención de salud 5*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*
	ID-006	*Intervención de salud 6*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*
Tratamiento	*ID-007*	*Intervención de salud 7*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*
Rehabilitación de la salud	*ID-009*	*Intervención de salud 9*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*
Cuidados paliativos	*ID-00N*	*Intervención de salud N*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*
ID		**Intervención de salud pública**	**Intervención en ejecución (Si o No)**	**Financiamiento (Indique la categoría presupuestal y las diferentes fuentes de financiamiento relacionadas a la intervención)**	**Barreras para la implementación**	**Facilitadores de la implementación (Coloque propuestas para abordar las barreras)**
ID-00X		Promover ambientes 100% libres de humo	Si	PP024	Desinformación sobre los riesgos del humo. Falta de cumplimiento de la normativa.	Campañas de sensibilización y educación Colaboración con actores clave Incentivos para los establecimientos.
ID-00Z		*Intervención de salud Z*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*

Ejemplo referencial

C. ALVARADO CH.

ANEXO 17

Herramienta 12: Diagrama de intervenciones de salud individual



MINISTERIO DE SALUD
C. ALVARADO CH.

Instructivo de la herramienta 12: Diagrama de intervenciones de salud individual

Esta herramienta tiene como finalidad dar soporte instrumental al equipo elaborador en la formulación del diagrama de intervenciones de salud individual, el cual debe estar en concordancia con la matriz de intervenciones de salud y responder de manera lógica y secuencial al cuidado integral de salud para la persona, familia y comunidad.

En el diagrama se identifica el ingreso a la VCIS de acuerdo con la necesidad de salud del sujeto de cuidado, incorpora los momentos de decisión, identifica los responsables de la ejecución, el escenario de cuidado, el cómo se concreta, los hitos, el soporte de la evidencia científica de las intervenciones de salud, el tiempo máximo de acuerdo a la oportunidad de la intervención de salud, así como las acciones del cuidado para la salud por parte de la persona, familia y comunidad.

El equipo elaborador correlaciona de manera secuencial las intervenciones de salud de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos según el alcance la VCIS. Así mismo, debe identificarse el RHUS que brinda la intervención de salud, los hitos, el parámetro normativo o de evidencia (GPC, documentos normativos, entre otros), intervenciones que implican toma de decisiones y responsabilidad de cada actor según rol, de tal manera que facilite la comprensión y visualización de la información relevante.

Para elaborar el diagrama de intervenciones de salud individual se recomienda el uso de herramientas para modelar procesos y se recomienda la siguiente simbología.

Símbolo	Detalle
	**Punto de inicio** Evento de inicio en la VCIS. Pueden ser identificados desde intervenciones de salud pública, intervenciones individuales, entre otras. Una VCIS puede tener tantos puntos de inicio como se considere.
	**Intervención de salud** Coloque la intervención de salud individual.
	**Decisión** En la VCIS se debe identificar aquellos puntos en los cuales se deben tomar decisiones que modifiquen el curso de la atención. Las decisiones podrán tener solo dos salidas.
	**Enlace a otras VCIS** Se debe identificar de forma explícita aquellos puntos donde se deben conectar las diferentes VCIS.
	**Referencia a E.S.** Se utiliza cuando el resultado de una intervención exige atención que no está cubierta por la VCIS. Representa la derivación del paciente a otro establecimiento de salud que cuenta con la capacidad resolutiva necesaria

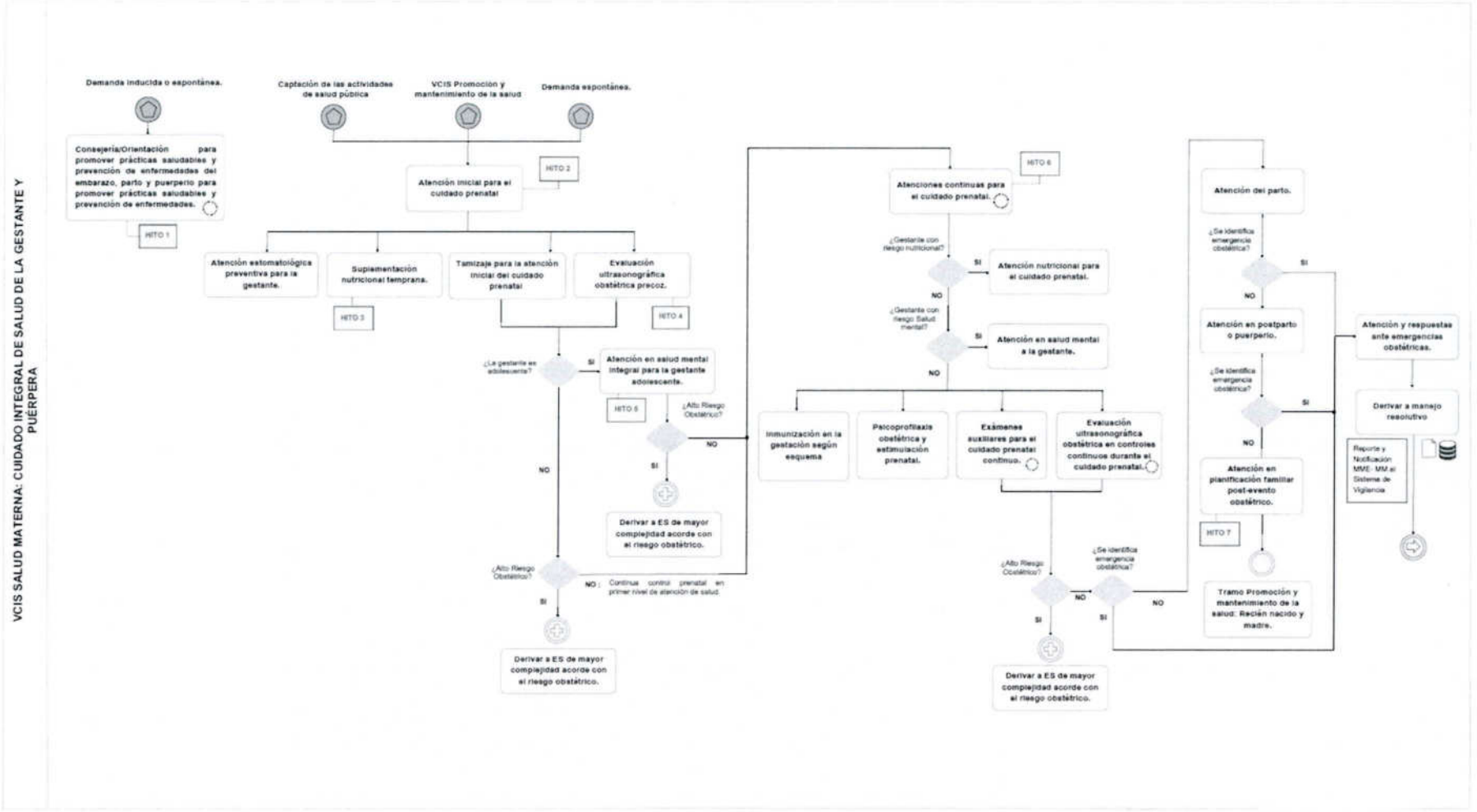
Símbolo	Detalle
	**Conector/evento intermedio de tiempo** Se usarán para representar plazos clínicos o administrativos obligatorios en la VCIS.
	**Conector/evento intermedio de mensaje** Se usarán para representar la espera de recibir información para continuar.
	**Base de datos** Representa el ingreso o salida de información relevante en el proceso.
	**Documentos** Representa un documento que sea relevante en el proceso.
	**Secuencia** Representa el control del flujo y secuencia de actividades
. . . . .	**Asociaciones** Se usa para asociar información adicional sobre el proceso o para asociar tareas complementarias.

C. ALVARADO CH.

Luego de cada sesión, el coordinador o algún integrante del equipo elaborador delegado, redacta el acta que contenga como mínimo lo siguiente:

1. Datos de identificación: Nombre de la reunión, fecha, hora de inicio y cierre, lugar o medio virtual, y número de sesión.
2. Participantes: nombres completos, cargos e institución de los asistentes.
3. Agenda u orden del día.
4. Desarrollo de las actividades: resumen de los temas tratados y principales aportes.
5. Registro de la Herramienta 12 (con avances o finalizada, según corresponda).
6. Acuerdos y compromisos: detalle de las decisiones, responsables y plazos.
7. Próxima fecha de reunión.
8. Firmas del coordinador, del responsable del acta y de los asistentes.

Ejemplo del registro de la Herramienta 12: Diagrama de intervenciones de salud individual

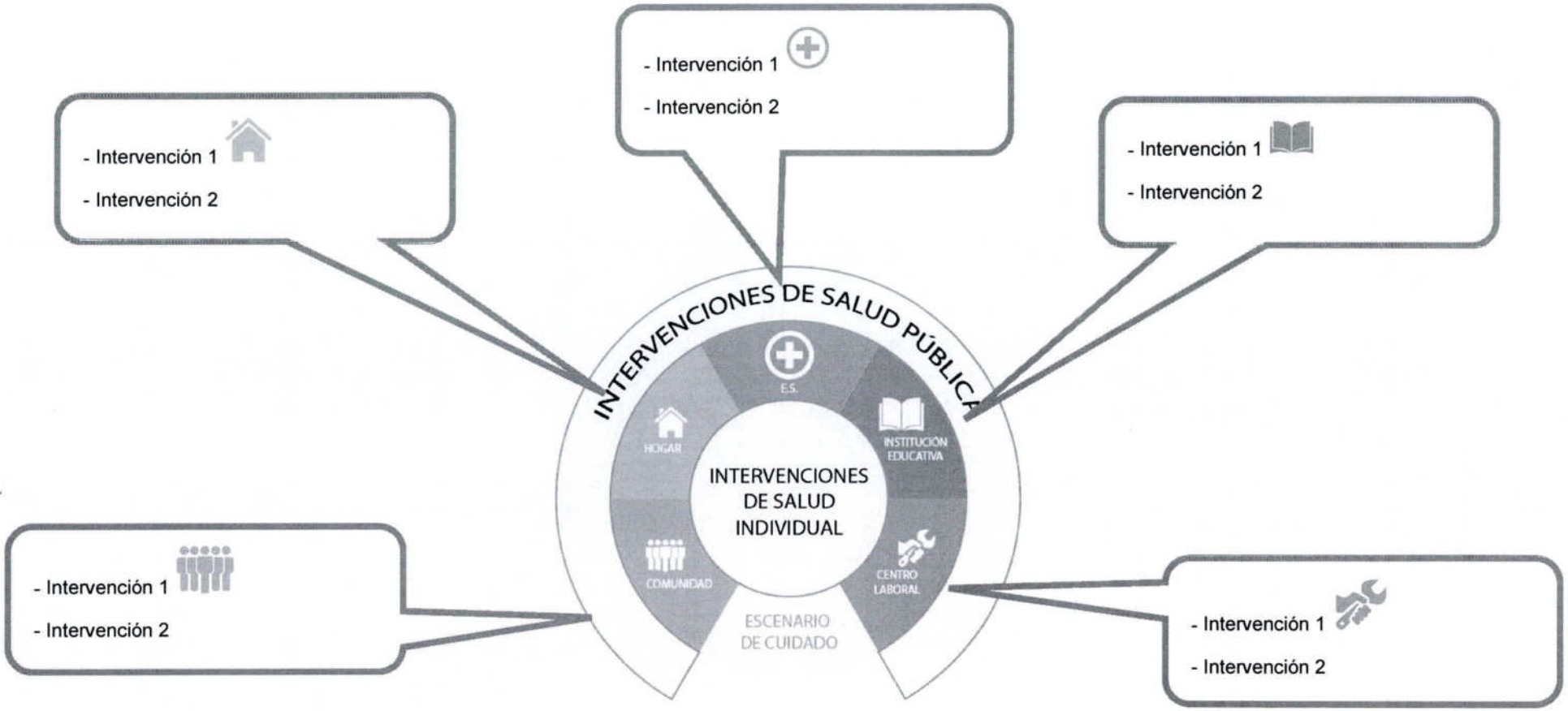


Ejemplo referencial

C. ALVARADO CH.

ANEXO 18

Herramienta 13: Diagrama de intervenciones de salud Pública



C. ALVARADO CH.

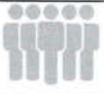
Instructivo de la herramienta 13: Diagrama de intervenciones de salud Pública

Esta herramienta tiene como finalidad dar soporte instrumental al equipo elaborador en la formulación del diagrama de intervenciones de salud pública, el cual debe estar en concordancia con la matriz de intervenciones de salud y responder de manera lógica y secuencial al cuidado integral de salud para la persona, familia y comunidad.

El equipo elaborador enlista las intervenciones de salud pública definitivas, en cada uno de los recuadros considerando el escenario de cuidado.

Los escenarios de cuidado pueden ser: Establecimiento de salud, hogar, Instituciones Educativas, centro laboral, comunidad, entre otros.

En el caso que la intervención de salud pública se realice en más de un escenario de cuidado organice la intervención de salud según los íconos, como se muestra a continuación:

Ícono	Denominación
	Establecimiento de salud
	Institución Educativa
	Centro Laboral
	Hogar
	Comunidad

Luego de cada sesión, el coordinador o algún integrante del equipo elaborador delegado, redacta el acta que contenga como mínimo lo siguiente:

1. Datos de identificación: Nombre de la reunión, fecha, hora de inicio y cierre, lugar o medio virtual, y número de sesión.
2. Participantes: nombres completos, cargos e institución de los asistentes.
3. Agenda u orden del día.
4. Desarrollo de las actividades: resumen de los temas tratados y principales aportes.
5. Registro de la Herramienta 13 (con avances o finalizada, según corresponda).
6. Acuerdos y compromisos: detalle de las decisiones, responsables y plazos.
7. Próxima fecha de reunión.
8. Firmas del coordinador, del responsable del acta y de los asistentes.

C. ALVARADO CH.

Ejemplo del registro de la Herramienta 13: Diagrama de intervenciones de salud Pública

Intervención 8: Fortalecimiento de alianzas estratégicas para la atención intersectorial de todas las formas de violencia.

Intervención 7: Promoción de la salud mental, la cultura del buen trato, la paz y la sana convivencia.

Intervención 6: Fortalecimiento de las coberturas de vacunación.

Intervención 5: Fortalecimiento de la implementación de sistemas de información en salud y otros vinculados para el registro de listados nominalizados

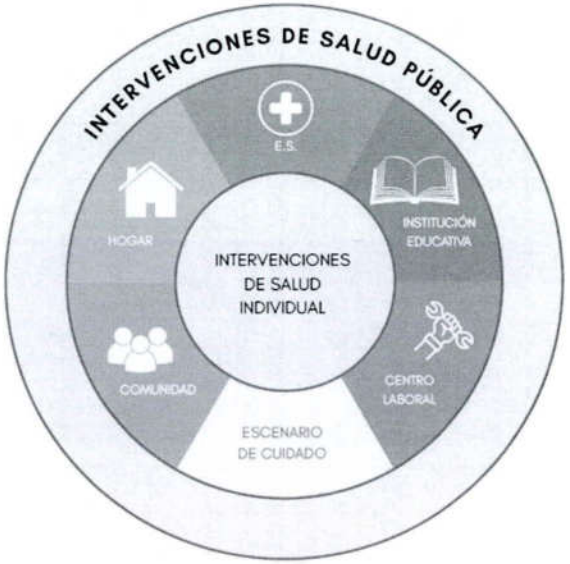
Intervención 4: Inscripción de todos los recién nacidos al Registro Nacional de Identidad y Estado Civil y al sistema de salud.

Intervención 3: Fortalecimiento de capacidades para la promoción de la lactancia materna exclusiva.

Intervención 2: Promoción de buenas prácticas en salud sexual y reproductiva según curso de vida.

Intervención 1: Fortalecimiento de prácticas de estilo de vida saludable y del autocuidado.

Intervención 9: Promoción de la vigilancia comunitaria para promover la canalización efectiva a las diferentes intervenciones individuales y de salud pública según curso de vida.



Herramienta 13: Diagrama de intervenciones de salud pública
VICIS Promoción y Mantenimiento de la Salud

Intervención 10: Gestión por niveles de gobierno para la implementación de escenarios y centros de promoción de la salud y bienestar.

Intervención 11: Fomento del cumplimiento de la regulación peruana antitabaco, nicotina y sucedáneos.

Intervención 12: Fomento y vigilancia de entornos y hábitos saludables para enfrentar riesgos del consumo de alcohol.

Intervención 13: Fomento de hábitos que prevengan el consumo de sustancias adictivas.

Intervención 14: Promoción de alimentación saludable.

Intervención 15: Fomento de la actividad física organizada y dirigida a la población según curso de vida.

Intervención 16: Educación para reducir la exposición a factores de riesgo por exposición ocupacional.

Intervención 17: Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las comunidades frente a los peligros que podrían generar crisis, emergencias y desastres y adaptación para el cambio climático.

Ejemplo referencial

Ejemplo del registro de la Herramienta 13: Diagrama de intervenciones de salud Pública



Herramienta 13: Diagrama de intervenciones de salud pública
VCIS Salud Materna

Ejemplo referencial

C. ALVARADO CH.

ANEXO 19

Pasos para la validación de la Vía de Cuidado Integral en Salud

A) Validación Interna

1. **Selección de los participantes.** – El equipo elaborador identifica y convoca en coordinación con la ANS a los representantes de los órganos y organismos del Ministerio de Salud relacionados con el objetivo y alcance de la VCIS.

2. **Presentación de la metodología para la elaboración de la VCIS.** – El equipo elaborador expone la metodología aplicada en la elaboración de la VCIS, con la finalidad de que los participantes comprendan su estructura y objetivo.

3. **Presentación de la VCIS.** – El equipo elaborador expone la matriz de intervenciones de salud, el diagrama de intervenciones de salud individual y el diagrama de intervenciones de salud pública.

4. **Entrega de insumos para la validación de la VCIS.** – El equipo elaborador proporciona a los participantes convocados, el diagrama y la matriz de intervenciones de salud de la VCIS, así como la matriz de validación interna de la VCIS, donde se consignan los aportes derivados del proceso de revisión. La matriz de validación interna de la VCIS se registra por cada participante.

5. **Reuniones con representantes seleccionados.** – Previa coordinación, el equipo elaborador convoca a los representantes seleccionados con la finalidad de exponer desde su perspectiva técnica los resultados de su validación a la VCIS.

6. **Análisis y ajuste de la VCIS.** – El equipo elaborador recoge y sistematiza los comentarios, sugerencias y aportes de cada participante en la validación interna, posteriormente realiza los ajustes necesarios, de corresponder, en el diseño de la VCIS según los resultados de la validación interna (ejemplo: cambios en la secuencia de las intervenciones de salud, incorporación o modificación de intervenciones de salud, entre otros).

7. **Presentación de los ajustes de la VCIS.** - El equipo elaborador presenta las modificaciones realizadas al diseño de la VCIS de acuerdo con los resultados de la validación interna, de corresponder. Si el equipo elaborador lo considera realiza una segunda ronda de validación para asegurar la coherencia y viabilidad de los cambios e incluso puede realizar visita a los establecimientos de salud del ámbito de una RIS seleccionada previamente.

8. **Informe final de validación.** – El equipo elaborador realiza el informe del proceso de validación interna, considerando los aportes y sugerencias recibidas y los ajustes realizados para la implementación de la VCIS, de corresponder, el cual es remitido a la ANS.

Matriz para la validación interna de la Vía de Cuidado Integral en Salud

Criterio	Verificador	Corresponde		Observaciones/Comentarios
		Si	No	
Intervenciones de salud seleccionadas con soporte en la evidencia científica disponible, marco normativo vigente o experiencia fundamentada del equipo elaborador de la VCIS.	Matriz de intervenciones de salud – Soporte de evidencia científica.			
Contenidos de la matriz de intervenciones de salud coherentes, comprensibles y claros.	Matriz de intervenciones de salud – Intervenciones de salud.			
Resultados esperados de la VCIS identificados.	Matriz de intervenciones de salud – Identificación y caracterización de los resultados esperados.			
Factores facilitadores y barreras de las intervenciones de salud de la VCIS identificados.	Matriz de intervenciones de salud – Barreras y facilitadores de la implementación			
Contenidos del diagrama de intervenciones de salud individual coherentes, comprensibles y claros.	Diagrama de intervenciones de salud individual.			
Contenidos del diagrama de intervenciones de salud pública coherentes, comprensibles y claros.	Diagrama de intervenciones de salud pública.			

C. ALVARADO CH.

B) Validación Externa

Posterior a la validación interna el equipo elaborador realiza la validación externa.

1. **Selección de los participantes.** – El equipo elaborador identifica y convoca en coordinación con la ANS a actores con experiencia y conocimiento en el alcance de la VCIS que se elabora entre los que destacan especialistas, docentes de Instituciones formadoras de Recursos Humanos en Salud, representantes de los colegios profesionales de las ciencias de la salud, representantes del Gobierno Nacional, Regional o Local, organizaciones que representen a los usuarios de salud, entre otros.

2. **Presentación de la metodología para la elaboración de la VCIS.** – El equipo elaborador expone la metodología aplicada en la elaboración de la VCIS, con la finalidad de que los participantes comprendan su estructura y objetivo.

3. **Presentación de la VCIS.** – El equipo elaborador expone la matriz de intervenciones de salud, el diagrama de intervenciones de salud individual y el diagrama de intervenciones de salud pública con validación interna.

9. **Entrega de insumos para la validación de la VCIS.** – El equipo elaborador proporciona a los participantes convocados, el diagrama y la matriz de intervenciones de salud de la VCIS, así como la matriz de validación externa de la VCIS, donde se consignan los aportes derivados del proceso de revisión. La matriz de validación externa de la VCIS se registra por cada participante.

4. **Reuniones con representantes seleccionados.** – Previa coordinación, el equipo elaborador convoca a los representantes seleccionados con la finalidad de exponer desde su perspectiva técnica los resultados de su validación a la VCIS.

5. **Análisis y ajuste de la VCIS.** – El equipo elaborador recoge y sistematiza los comentarios, sugerencias y aportes de cada participante en la validación externa, posteriormente realiza los ajustes necesarios, de corresponder, en el diseño de la VCIS según los resultados de la validación externa (ejemplo: cambios en la secuencia de las intervenciones de salud, incorporación o modificación de intervenciones de salud, entre otros).



6. **Presentación de los ajustes de la VCIS.** - El equipo elaborador presenta las modificaciones realizadas al diseño de la VCIS de acuerdo con los resultados de la validación externa, de corresponder. Si el equipo elaborador lo considera realiza una segunda ronda de validación para asegurar la coherencia y viabilidad de los cambios.

7. **Informe final de validación.** – El equipo elaborador prepara un informe sobre el proceso de validación externa, los aportes y sugerencias recibidas y los ajustes realizados para la implementación de la VCIS, de corresponder, el cual es remitido a la ANS.

Matriz para la validación externa de la Vía de Cuidado Integral en Salud

Criterio	Verificador	Corresponde		Observaciones/Comentarios
		Si	No	
Intervenciones de salud seleccionadas con soporte en la evidencia científica disponible, marco normativo vigente o experiencia fundamentada del equipo elaborador de la VCIS.	Matriz de intervenciones de salud – Soporte de evidencia científica.			
Contenidos de la matriz de intervenciones de salud coherentes, comprensibles y claros.	Matriz de intervenciones de salud – Intervenciones de salud.			
Resultados esperados de la VCIS identificados.	Matriz de intervenciones de salud – Identificación y caracterización de los resultados esperados.			
Factores facilitadores y barreras de las intervenciones de salud de la VCIS identificados.	Matriz de intervenciones de salud – Barreras y facilitadores de la implementación			
Contenidos del diagrama de intervenciones de salud individual coherentes, comprensibles y claros.	Diagrama de intervenciones de salud individual.			
Contenidos del diagrama de intervenciones de salud pública coherentes, comprensibles y claros.	Diagrama de intervenciones de salud pública.			

C. ALVARADO CH.

Anexo 20

Pasos para la adecuación de la VCIS en la RIS

Los Gestores de la RIS identifican y seleccionan del listado de VCIS aprobadas por la ANS, la VCIS a implementar, el mismo que deberán adecuar considerando su ámbito territorial para posteriormente ser aprobado por la ARS o DIRIS LM, según corresponda.

Para la adecuación de la VCIS la RIS considera los mecanismos para el abordaje de las intervenciones de salud establecidas en la VCIS, las características geográficas del territorio y los resultados esperados en la persona, familia y comunidad.

La adecuación debe seguir los siguientes pasos:

1. **Revisión de la VCIS priorizada**
   Corresponde al análisis del contenido técnico de la VCIS aprobada por la ANS, e identificación de las intervenciones de salud definidas.

2. **Análisis territorial**
   Evaluación del contexto de la RIS: características geográficas, perfil epidemiológico, red prestadora, recursos disponibles, barreras de acceso, entre otras.

3. **Análisis de factores barreras y facilitadores**
   Corresponde a la identificación de factores que limitan o favorecen la implementación de cada intervención de salud, considerando la factibilidad operativa, recursos disponibles, accesibilidad, pertinencia cultural y sostenibilidad en el ámbito territorial.

4. **Identificación de las intervenciones de salud que requieren de estrategias diferenciadas**
   Corresponde a la determinación de intervenciones de salud que, por su complejidad, novedad o brechas en el territorio, necesitan medidas específicas para garantizar su implementación efectiva en el ámbito territorial de la RIS.

C. ALVARADO CH.

5. **Diseño de las estrategias para la implementación de las intervenciones de salud en el ámbito territorial**
   Corresponde a la formulación de estrategias operativas, logísticas u organizativas para adaptar las intervenciones de salud al contexto local. Esto puede incluir la reorganización de flujos de atención, fortalecimiento de capacidades locales, articulación interinstitucional, adecuación de tiempos o niveles de resolución, entre otras.

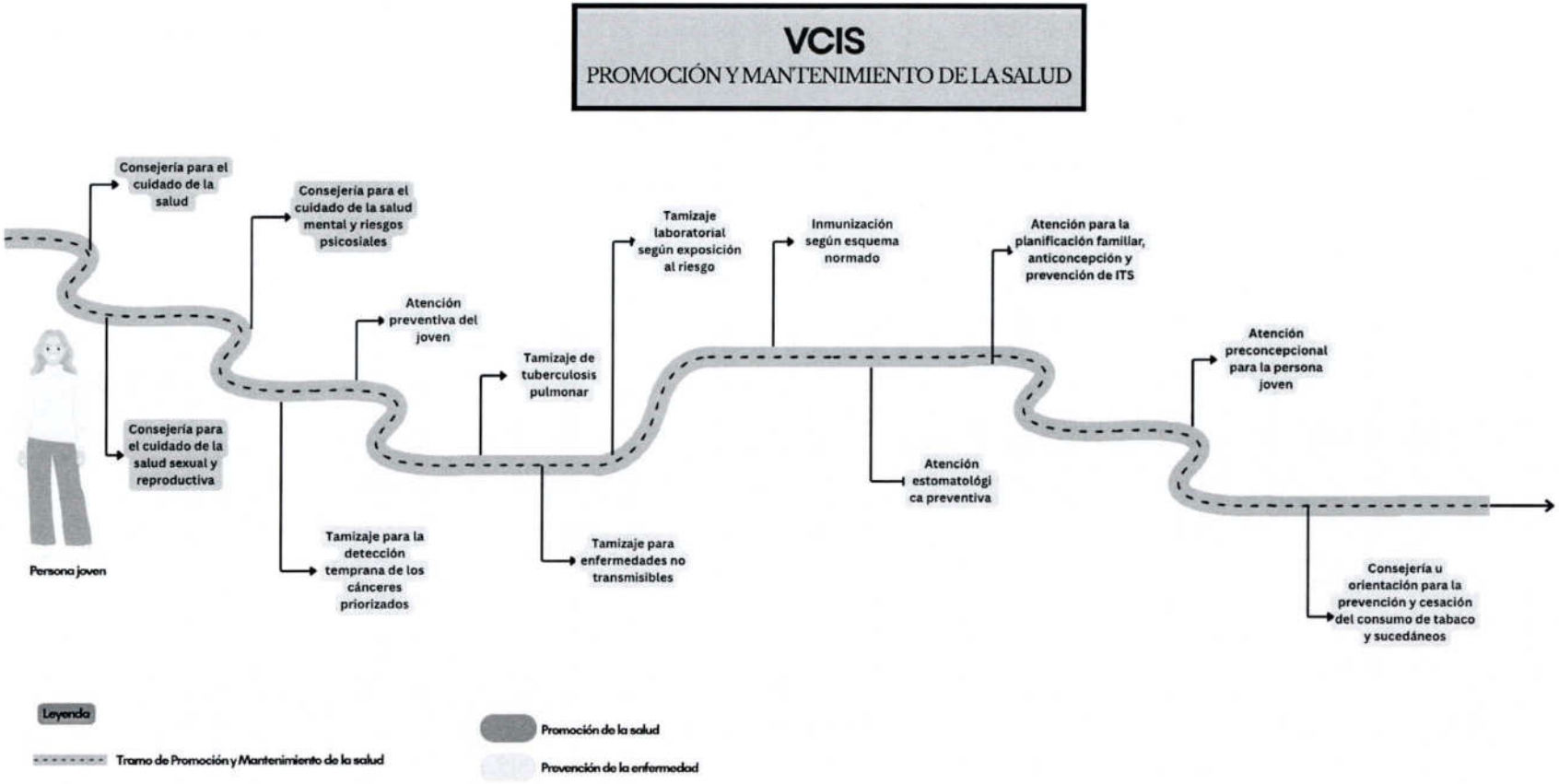
6. **Validación de las estrategias con los Gestores de la RIS**
   Corresponde a la revisión participativa y validación técnica de las estrategias planteadas, con los equipos técnicos de la RIS, asegurando la viabilidad de su ejecución.

Precisiones adicionales:

- La intervención de salud definida en la VCIS aprobada por la ANS, **no se modifica.**
- La adecuación se centra en el ***cómo*** hacer operativa la intervención de salud en función del contexto territorial: accesibilidad, referencia, capacidad instalada, disponibilidad de recursos, entre otros.

Anexo 21

Ejemplo ilustrativo del recorrido de la persona joven en la VCIS de Promoción y Mantenimiento de la salud

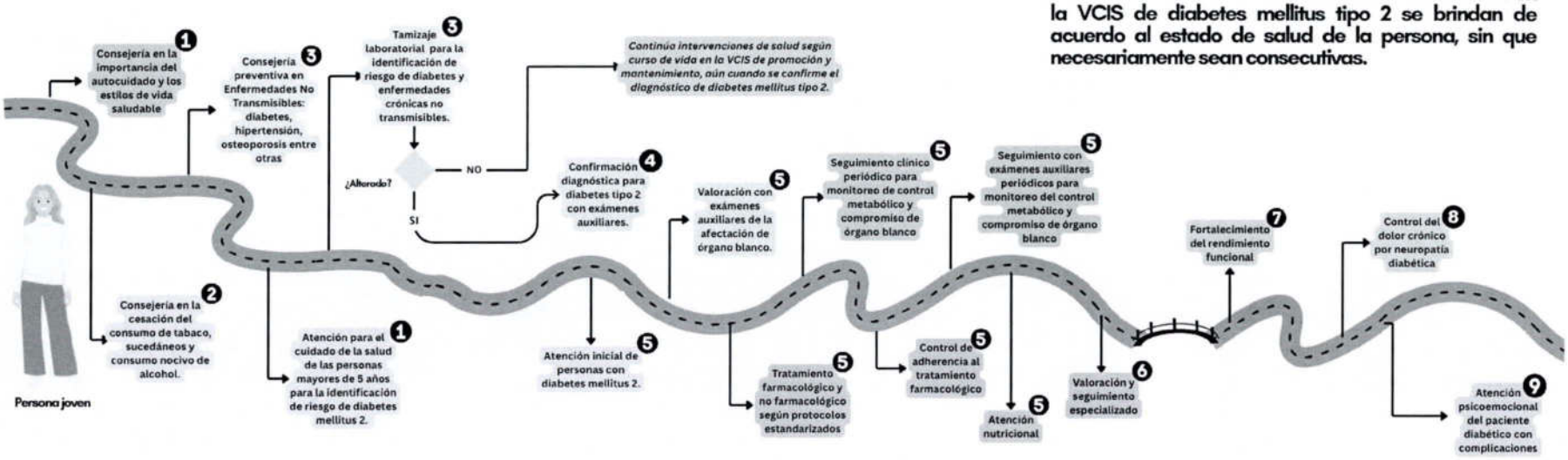


Ejemplo referencial

Ejemplo ilustrativo del recorrido de la persona en la VCIS de Diabetes Mellitus tipo 2

VCIS
Diabetes Mellitus tipo 2

Las intervenciones de salud individual establecidas en la VCIS de diabetes mellitus tipo 2 se brindan de acuerdo al estado de salud de la persona, sin que necesariamente sean consecutivas.



Leyenda

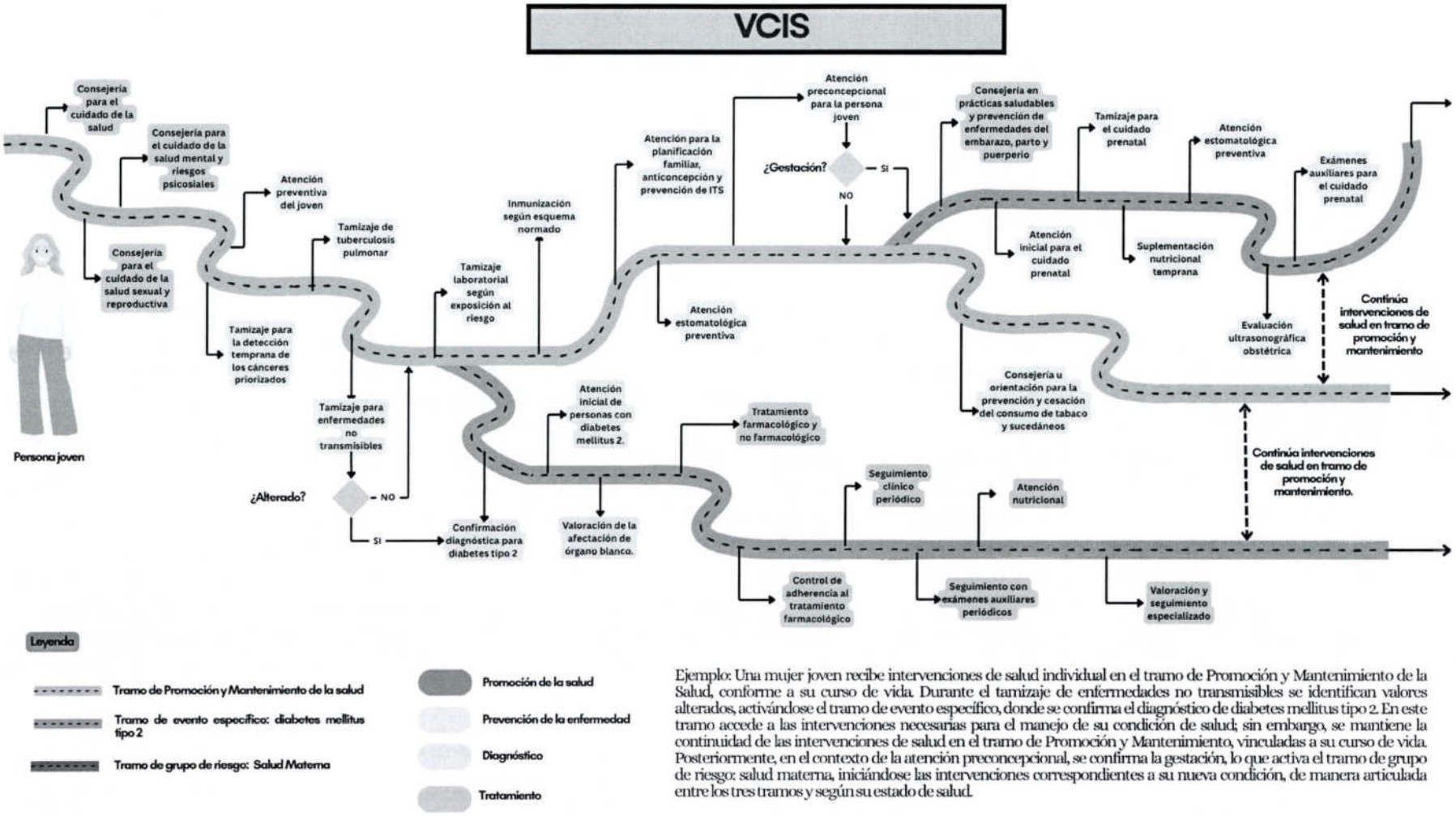
- Tramo de evento específico diabetes mellitus tipo 2
- Derivación según evolución clínica
- Promoción de la salud
- Prevención de la enfermedad
- Diagnóstico
- Tratamiento
- Rehabilitación de la salud
- Cuidados paliativos

1. Intervención de salud dirigida a población mayor de 5 años
2. Intervención de salud dirigida a población mayor de 12 años
3. Intervención de salud dirigida a jóvenes y adultos sanos y personas con factores de riesgo para ENT.
4. Intervención de salud dirigida a población mayor de 5 años con sospecha de diabetes
5. Intervención de salud dirigida a paciente con diagnóstico de diabetes mellitus 2
6. Intervención de salud dirigida a paciente con diagnóstico de diabetes mellitus 2 con complicación o mal control metabólico
7. Intervención de salud dirigida a paciente con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2,en los que se identifica alteración del estado funcional.
8. Intervención de salud dirigida a paciente con Diabetes 2 con neuropatía diabética o dolor crónico.
9. Intervención de salud dirigida a paciente con diagnóstico de diabetes mellitus 2 con complicación.

Ejemplo referencial

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

Ejemplo ilustrativo del recorrido de la persona en los diferentes tramos de las VCIS



Ejemplo: Una mujer joven recibe intervenciones de salud individual en el tramo de Promoción y Mantenimiento de la Salud, conforme a su curso de vida. Durante el tamizaje de enfermedades no transmisibles se identifican valores alterados, activándose el tramo de evento específico, donde se confirma el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. En este tramo accede a las intervenciones necesarias para el manejo de su condición de salud; sin embargo, se mantiene la continuidad de las intervenciones de salud en el tramo de Promoción y Mantenimiento, vinculadas a su curso de vida. Posteriormente, en el contexto de la atención preconcepcional, se confirma la gestación, lo que activa el tramo de grupo de riesgo: salud materna, iniciándose las intervenciones correspondientes a su nueva condición, de manera articulada entre los tres tramos y según su estado de salud.

Ejemplo referencial

C. ALVARADO CH

X. BIBLIOGRAFÍA

1. Perú. Decreto Supremo N.° 008-2017-SA. Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. 5 mar 2017. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/190095-008-2017-sa
2. Perú. Decreto Supremo N.° 026-2020-SA. Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 "Perú, País Saludable". 24 ago 2020. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/1113419-026-2020-sa
3. Perú. Decreto Supremo N.° 019-2024-SA. Reglamento de la Ley N° 30885, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud-RIS 21 oct 2024. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/6111817-019-2024-sa
4. Estonian Health Insurance Fund. Estonian handbook for guidelines development 2011 (Estonian adaptation). 2021. Disponible en: https://tervis.ut.ee/sites/default/files/inline-files/estonian_handbook_for_guidelines_development_2020.pdf
5. Perú. Ley N.° 30895. Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud, y garantiza el ejercicio. 28 dic 2018. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/235717-30895
6. Perú. Ley N.° 27658. Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 30 ene 2002. Disponible en: https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/BCE7AB2E6434B55305257B890053B271/$FILE/02A08.pdf
7. Ministerio de Salud y Protección Social (Colombia). Manual metodológico para la elaboración e implementación de las RIAS. Bogotá D.C.; 2016. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/Manual-metodologico-rias.pdf
8. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS). Elaboración de guías de práctica clínica en el Sistema Nacional de Salud. Actualización del manual metodológico. Zaragoza: ARPirelieve S.A.; 2016. Disponible en: https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2019/01/manual_gpc_completo.pdf
9. Ministry of Health (Saudi Arabia). Saudi Arabian handbook for healthcare guideline development. 2014. Disponible en: https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/Structure/Programs/TCP/Documents/Saudi%20Arabian%20Handbook%20for%20Healthcare%20Guideine%20Development-updated16-7.pdf
10. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Developing NICE guidelines: the manual. 2022. Disponible en: https://www.nice.org.uk/process/pmg20/chapter/introduction
11. Perú. Resolución Ministerial N.° 030-2020-MINSA. Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comunidad (MCI). 27 ene 2020. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/414755-030-2020-minsa

C. ALVARADO CH.

12. Perú. Resolución Ministerial N.° 220-2021-MINSA. Manual de Implementación del Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comunidad (MCI). 15 feb 2021. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/1682527-220-2021-minsa

13. Perú. Resolución Ministerial N.° 327-2022-MINSA. Directiva Administrativa N.° 329-MINSA/DGAIN-2022. Directiva Administrativa de Conformación de Redes Integradas de Salud-RIS. 7 may 2022. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/2950890-327-2022-minsa

14. Perú. Resolución Ministerial N.° 414-2015-MINSA. Metodología para la elaboración de Guías de Práctica Clínica. 1 jul 2015. Disponible en: https://www.irennorte.gob.pe/pdf/normatividad/documentos_normativos/MINSA/MANUALES/2015%20RM_414%20PARTE_I%20METODOLOGIA%20ELABORACION%20GPC.pdf

15. Perú. Resolución Ministerial N.° 826-2021-MINSA. Normas para la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud. 11 jul 2021. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/2017438-826-2021-minsa

16. Saturno Hernández PJ. Cómo lograr la excelencia en la atención sanitaria: construcción, implementación y evaluación de vías clínicas. 1a ed. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2018. ISBN: 978-607-511-177-3. Disponible en: https://www.insp.mx/images/stories/2018/Docs/180914_ManualVias_Clinicas.pdf